AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

NEUROLOGÍA

90 preguntas de práctica

Geriatría

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Neurología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 10 · PARTE A: POR BLOQUES

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES					
1.10.1.003	Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.001	Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5)
1.10.2.002	Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9, Q10	Tomo 10 · 10.2 (Pág. 9)
1.10.2.003	Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12, Q13, Q14, Q15	Tomo 10 · 10.3 (Pág. 11)
1.10.2.004	Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15)
1.10.2.005	Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 10 · 10.5 (Pág. 19)
1.10.2.007	Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7, Q8	Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5)
1.10.2.008	Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q17	Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15)
1.10.2.009	Hipertensión endocraneana	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.021	Traumatismo encefalocraneano grave	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	—	Q2	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
BLOQUE 2: CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA					
1.10.1.001	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q22	Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26)
1.10.1.007	Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33	Tomo 10 · 10.8 (Pág. 30)
1.10.1.012	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg:	GES	Q23	Tomo 10 · 10.6 (Pág. 24)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Tensional	**Realizar**			
1.10.1.013	Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 10 · 10.7 (Pág. 28)
1.10.1.018	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q24	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.019	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q25	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.021	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q26	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.022	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q27	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.023	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q28	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.024	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q29	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.010	Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q34	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.012	Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q32	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.014	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q30	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.015	Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q21	Tomo 10 · 10.10 (Pág. 38)
1.10.2.016	urémico, etc)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.017	con meningitis purulenta o bacteriana	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.018	Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 10 · 10.9 (Pág. 34)
1.10.2.019	Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q36	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
BLOQUE 3: TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS					
1.10.1.004	Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 10 · C.3 (Pág. 10)
1.10.1.005	Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52, Q53	Tomo 10 · 10.14 (Pág. 51)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.10.1.006	Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q46, Q47	Tomo 10 · 10.11 (Pág. 43)
1.10.1.026	Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q48, Q49, Q50	Tomo 10 · 10.13 (Pág. 49)
1.10.1.027	Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q45	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.028	Tumores de región sellar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q38	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.029	Tumores primarios y metastásicos SNC	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.011	Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q51	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.020	Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q54	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
BLOQUE 4: PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO					
1.10.1.008	Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68	Tomo 10 · 10.18 (Pág. 68)
1.10.1.009	Herpes zoster	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	—	Q55	Tomo 10 · C.5 (Pág. 14)
1.10.1.010	Lumbago mecánico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q56	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.011	Lumbociáticas y cervicobraquialgias.	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q57	Tomo 10 · C.6 (Pág. 16)
1.10.1.014	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q69	Tomo 10 · C.7 (Pág. 18)
1.10.1.015	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 10 · C.11 (Pág. 26)
1.10.1.016	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Realizar**	GES	Q71	Tomo 10 · 10.19 (Pág. 72)
1.10.1.017	Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc...	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q58	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.020	Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q64, Q65, Q66, Q67	Tomo 10 · 10.17 (Pág. 64)
1.10.1.025	Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 10 · 10.20 (Pág. 74)
1.10.2.013	Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q59, Q60, Q61, Q62, Q63	Tomo 10 · 10.16 (Pág. 60)
BLOQUE 5: GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS					

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.07.1.001	Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial / Derivación** · Seg: **Urgencia traumatológica / Ortogeriatría**	GES	Q85, Q86, Q87	Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85)
1.07.1.008	Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio**	GES	Q81, Q82, Q83, Q84	Tomo 10 · 10.22 (Pág. 83)
1.07.2.005	Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Hospitalario / Ambulatorio**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 10 · 10.21 (Pág. 79)
1.07.3.007	Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio**	GES	Q88, Q89, Q90	Tomo 10 · 10.24 (Pág. 87)
1.10.1.002	Compromiso de conciencia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.006	Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q74	Tomo 11 · 11.12 (Pág. 57)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Neurología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.07.1.001	Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial / Derivación** · Seg: **Urgencia traumatológica / Ortogeriatría**	GES	Q85, Q86, Q87	Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85)
1.07.1.008	Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio**	GES	Q81, Q82, Q83, Q84	Tomo 10 · 10.22 (Pág. 83)
1.07.2.005	Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Hospitalario / Ambulatorio**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 10 · 10.21 (Pág. 79)
1.07.3.007	Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio**	GES	Q88, Q89, Q90	Tomo 10 · 10.24 (Pág. 87)
1.10.1.001	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q22	Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26)
1.10.1.002	Compromiso de conciencia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.003	Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.004	Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 10 · C.3 (Pág. 10)
1.10.1.005	Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52, Q53	Tomo 10 · 10.14 (Pág. 51)
1.10.1.006	Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q46, Q47	Tomo 10 · 10.11 (Pág. 43)
1.10.1.007	Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33	Tomo 10 · 10.8 (Pág. 30)
1.10.1.008	Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68	Tomo 10 · 10.18 (Pág. 68)
1.10.1.009	Herpes zoster	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	—	Q55	Tomo 10 · C.5 (Pág. 14)
1.10.1.010	Lumbago mecánico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q56	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.011	Lumbociáticas y cervicobraquialgias.	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q57	Tomo 10 · C.6 (Pág. 16)
1.10.1.012	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg:	GES	Q23	Tomo 10 · 10.6 (Pág. 24)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Tensional	**Realizar**			
1.10.1.013	Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 10 · 10.7 (Pág. 28)
1.10.1.014	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q69	Tomo 10 · C.7 (Pág. 18)
1.10.1.015	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 10 · C.11 (Pág. 26)
1.10.1.016	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Realizar**	GES	Q71	Tomo 10 · 10.19 (Pág. 72)
1.10.1.017	Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc...	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q58	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.018	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q24	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.019	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q25	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.020	Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q64, Q65, Q66, Q67	Tomo 10 · 10.17 (Pág. 64)
1.10.1.021	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q26	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.022	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q27	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.023	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q28	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.024	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q29	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.025	Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 10 · 10.20 (Pág. 74)
1.10.1.026	Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q48, Q49, Q50	Tomo 10 · 10.13 (Pág. 49)
1.10.1.027	Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q45	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.028	Tumores de región sellar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q38	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.029	Tumores primarios y metastásicos SNC	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.001	Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.10.2.002	Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9, Q10	Tomo 10 · 10.2 (Pág. 9)
1.10.2.003	Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12, Q13, Q14, Q15	Tomo 10 · 10.3 (Pág. 11)
1.10.2.004	Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15)
1.10.2.005	Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 10 · 10.5 (Pág. 19)
1.10.2.006	Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q74	Tomo 11 · 11.12 (Pág. 57)
1.10.2.007	Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7, Q8	Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5)
1.10.2.008	Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q17	Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15)
1.10.2.009	Hipertensión endocraneana	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.010	Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q34	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.011	Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q51	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.012	Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q32	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.013	Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q59, Q60, Q61, Q62, Q63	Tomo 10 · 10.16 (Pág. 60)
1.10.2.014	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q30	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.015	Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q21	Tomo 10 · 10.10 (Pág. 38)
1.10.2.016	urémico, etc)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.017	con meningitis purulenta o bacteriana	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.10.2.018	**Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo**	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 10 · 10.9 (Pág. 34)
1.10.2.019	**Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo**	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q36	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.020	**Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve**	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q54	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.021	**Traumatismo encefalocraneano grave**	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	—	Q2	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

PREGUNTA 1 — 1.10.2.009

1. [URGENCIA: Hipertensión endocraneana · 1.10.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hipertensión endocraneana. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 2 — 1.10.2.021

2. Un adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito, en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con escala de Glasgow de 15. Se solicita una radiografía de cráneo que muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hematoma subdural derecho
B) Hematoma epidural derecho
C) Hemorragia subaracnoidea
D) Contusión encefálica frontal
E) Contusión encefálica temporal

PREGUNTA 3 — 1.10.2.001

3. Un paciente de 55 años sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media, el que es manejado oportunamente con trombolisis endovenosa, permaneciendo sólo con una leve hemiparesia izquierda. Se realiza ECG que resulta normal, ecocardiografía sin alteraciones y ecografía-doppler carotídea con estenosis carotídea derecha de 60% y estenosis carotídea izquierda de 40%. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar anticoagulación oral y controlar los factores de riesgo cardiovascular
B) Iniciar aspirina y controlar los factores de riesgo cardiovascular
C) Realizar endarterectomía derecha
D) Realizar endarterectomía bilateral
E) Solicitar angiografía carotídea

PREGUNTA 4 — 1.10.2.001, 1.10.2.007

4. Un paciente de 55 años sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media, el que es manejado oportunamente con trombolisis endovenosa, permaneciendo sólo con una leve hemiparesia izquierda. Se realiza ECG que resulta normal, ecocardiografía sin alteraciones y ecografía-doppler carotídea con estenosis carotídea derecha de 60% y estenosis carotídea izquierda de 40%. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar anticoagulación oral y controlar los factores de riesgo cardiovascular
B) Iniciar aspirina y controlar los factores de riesgo cardiovascular
C) Realizar endarterectomía derecha
D) Realizar endarterectomía bilateral
E) Solicitar angiografía carotídea

PREGUNTA 5 — 1.10.2.001, 1.10.2.007

5. Un paciente de 67 años, hipertenso y diabético presenta de forma súbita una hemiparesia derecha, asociada a afasia, de 30 minutos de duración. Se solicita TAC de cerebro que descarta hemorragias. Es manejado adecuadamente, con medidas de neuroprotección y afortunadamente, los síntomas inician una recuperación espontánea antes de comenzar el protocolo de trombolisis. Al segundo día está en excelentes condiciones, sin déficit neurológico ni otras alteraciones del examen físico. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar TAC de cerebro control
B) Solicitar electroencefalograma
C) Solicitar Holter de arritmias, ecocardiograma y eco-doppler carotideo
D) Iniciar aspirina
E) Iniciar anticoagulación oral a permanencia

PREGUNTA 6 — 1.10.2.001, 1.10.2.007

6. Un paciente de 60 años, portador de una ACxFA tratada con atenolol y anticoagulación oral, consulta por hemiparesia izquierda, de inicio súbito hace 1 hora, asociada a hemihipoestesia ipsilateral. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
B) Solicitar electroencefalograma
C) Iniciar anticoagulación con heparina
D) Realizar trombolisis endovenosa
E) Solicitar angiografía carotidea

PREGUNTA 7 1.10.2.001, 1.10.2.007

7. Ingresa a SU hombre de 72 años, HTA, DM2, dislipidemia, con 1 hora de evolución de afasia asociada a hemiparesia derecha. Se solicita TAC de cerebro que no muestra alteraciones. Su conducta siguiente sería:

A) Inicio de AAS asociado a Acenocumarol (Neosintrom) e ingreso a intermedio.
B) Inicio de AAS 250 mg al día, heparina estandar por BIC e ingreso a UCI.
C) Inicio de trombolisis por SK asociado a heparina no fraccionada.
D) Dejar en evolución espontánea, se encuentra fuera de alcance terapéutico.
E) Inicio de trombolisis con tPA.

PREGUNTA 8 1.10.2.007

8. Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para hablar. Al examen físico tiene hemiparesia faciobraquiocrural derecha y afasia. Su TAC de cerebro es normal. La conducta más adecuada es:

A) Anticoagular con heparina
B) Administrar antiagregantes plaquetarios
C) Solicitar resonancia magnética nuclear
D) Realizar embolectomía
E) Realizar trombólisis

PREGUNTA 9 1.10.2.002

9. Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable), hipertensión arterial bien controlada y diabetes mellitus tipo 2, consulta por un episodio de AIT (ataque isquémico transitorio). En la tomografía axial computarizada no se observan cambios en la imagen cerebral previa y en el electrocardiograma se confirma la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular normal, cuya reversión a ritmo sinusal, tanto eléctrica como farmacológica, había fracasado previamente. En la ecografía se observa la existencia de una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Los días antes del último episodio seguía tratamiento con aspirina (150 mg diarios). ¿Cuál sería su consejo terapéutico?:

A) Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.
B) Sustituiría la aspirina por clopidogrel.
C) Añadiría clopidogrel a la aspirina
D) Duplicaría la dosis de aspirina.
E) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica

PREGUNTA 10 1.10.2.002

10. Un paciente de 46 años, portador de una ACxFA crónica, en tratamiento con aspirina, presenta bruscamente imposibilidad para hablar y entender el lenguaje, asociado a hemiparesia derecha, de 30 minutos de duración, que ceden espontáneamente. Al examen físico está completamente normal, excepto por el pulso irregular a 80x'. La conducta más adecuada es:

A) Enviar a domicilio, indicando anticoagulación con cumarínicos
B) Administrar heparina de bajo peso molecular y enviar a domicilio, con nuevas dosis subcutáneas, cada 12 horas
C) Solicitar TAC de cerebro y mantener aspirina
D) Enviar a domicilio, indicando control ambulatorio con el neurólogo
E) Hospitalizar, iniciar anticoagulación con heparina, solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro e iniciar medidas de neuroprotección

PREGUNTA 11 1.10.1.003

11. Hombre de 72 años con cefalea holocraneal progresiva de 3 meses de evolución, asociada a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. TAC de cerebro: colección hipodensa crónicamente organizada entre el córtex y el hueso craneal, sin efecto de masa severo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tumor cerebral primario
B) Metástasis cerebrales
C) Hematoma subdural crónico
D) Hidrocefalia normotensiva
E) Enfermedad de Alzheimer

PREGUNTA 12 1.10.2.003

12. Una mujer de 17 años, presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha, cayendo al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que mantuvo mirada conjugada hacia derecha, tras lo cual presentó hipertonía de todo el cuerpo, seguido de movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Se recupera somnolienta y adolorida, con signos de haberse mordido la lengua, con impresión de la arcada dentaria en zona lateral de la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Crisis convulsiva primariamente generalizada
B) Crisis focal secundariamente generalizado
C) Síncope vasovagal
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno facticio

PREGUNTA 13 1.10.2.003

13. Un niño de 4 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre, asociado a rigidez de nuca en el examen físico. Se decide realizar punción lumbar, luego de descartar la presencia de hipertensión endocraneana con un TAC de cerebro, y se obtiene un líquido cefalorraquídeo claro, con 60 células por mm3, con 99% de mononucleares (linfocitos), proteínas: 50 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Meningitis tuberculosa
B) Meningitis bacteriana
C) Meningitis herpética
D) Meningitis viral
E) Sano

PREGUNTA 14 1.10.2.003

14. Paciente de 45 años, diabético mal controlado, consulta por fiebre, tos productiva, disnea de reposo y finalmente compromiso de conciencia. Al examen se aprecia paciente en malas condiciones generales, con pulso: 140 lpm, regular, presión arterial: 80/40 mmHg, frecuencia respiratoria: 38 rpm, Glasgow: 10. En el examen segmentario destacan crépitos en base derecha y campo pulmonar izquierdo. Se inicia resucitación con suro fisiológico y oxígenos, logrando saturación arterial de 88% a FiO2: 50% y presión arterial: 100/58 mmHg. El tratamiento antibiótico para este paciente debe ser:

A) Ceftriaxona + Amicacina
B) Ceftriaxona + Vancomicina
C) Cefotaximo + Ampicilina
D) Ceftriaxona + Claritromicina
E) Cefotaximo + Metronidazol

PREGUNTA 15 1.10.2.003

15. Mujer de 64 años, ingresa por un accidente de tránsito. Inicialmente presenta hipotensión y oliguria. En sus exámenes destaca Crea:3,9 y BUN:80. Se administra volumen con suero fisiológico y se realiza tratamiento endoscópico de la úlcera, con buen resultado. Se mantiene con presión arterial cercana a 110/70. Al 3er día reinicia diuresis, cercanas a 1.000cc/día, sin embargo persiste con crea: 3,5. El sodio urinario es de 5mEq/l, el sodio plasmático es de 140mEq/l y la creatinina urinaria es de 25 mg/dl. La causa más probable de su alteración de la función renal es:

A) Hipovolemia con compromiso prerrenal
B) Necrosis tubular aguda
C) Nefropatía diabética
D) Nefritis intersticial
E) Rabdomiolisis

PREGUNTA 16 1.10.2.004

16. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una hemorragia subaracnoídea por rotura de un aneurisma?

A) Cefalea opresiva occipital, con dolor a la palpación de los músculos cervicales posteriores
B) Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos
C) Cefalea intensa, pulsátil, frontal, asociada a fotopsias
D) Cefalea de rápida instalación, asociada a hemiparesia derecha y abolición de los reflejos osteotendíneos derechos
E) Cefalea progresiva, mayor con el decúbito, asociado a vómitos y edema de papila

PREGUNTA 17 1.10.2.008

17. Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha acompañado de vómitos alimentarios. Al examen físico está vigil y orientada, adolorida, con FC: 70x', PA: 140/90 mmHg, en el examen neurológico tiene signos meníngeos presentes, sin alteraciones motoras ni sensitivas. Se solicita TAC de cerebro sin contraste, que muestra hiperdensidad del espacio intercomisural frontal y del espacio subaracnoideo basal. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Resonancia magnética nuclear de cerebro
B) Punción lumbar
C) TAC de cerebro con contraste
D) Angiografía cerebral
E) Ecocardiograma

PREGUNTA 18 1.10.2.005

18. Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemdinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada (heparina de alto peso molecular) por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?

A) Tiempo de protrombina (TP) e INR
B) Tiempo de trombina (TT)
C) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
D) Tiempo de sangría
E) No requiere control con exámenes

BLOQUE 2 CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

PREGUNTA 19 1.10.2.016

19. [URGENCIA: urémico, etc) · 1.10.2.016] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de urémico, etc). Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 20 1.10.2.017

20. [URGENCIA: con meningitis purulenta o bacteriana · 1.10.2.017] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de con meningitis purulenta o bacteriana. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 21 1.10.2.015

21. Un adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra una lesión quística de 3 cm en la zona frontotemporal y se realiza una punción lumbar, que muestra proteínas 60 mg/dl, con 70 células por mm3, con 70% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste aracnoidal
B) Astrocitoma pilocítico
C) Encefalitis herpética
D) Meningitis tuberculosa
E) Neurocisticercosis

PREGUNTA 22 1.10.1.001

22. Un paciente de 40 años consulta por cefalea holocránea, mayor en la zona occipital, que se irradia al cuello. Suele iniciarse a medio día y alcanza su máxima intensidad al llegar a su casa, después del trabajo. Su examen neurológico no tiene signos focales ni meníngeos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cefalea tensional
B) Migraña
C) Cefalea en racimo o cluster
D) Cefalea por hipertensión endocraneana
E) Neuralgia de Arnold

PREGUNTA 23 1.10.1.012

23. Existen tratamientos profilácticos para la migraña, que disminuyen la frecuencia y la intensidad de los episodios de jaqueca. Todos los medicamentos enumerados a continuación pueden ser usados como tratamiento profiláctico, EXCEPTO:

A) Sumatriptán
B) Propanolol
C) Ácido valproico6
D) Flunarizina
E) Amitriptilina

PREGUNTA 24 1.10.1.018

24. Un paciente de 75 años, con antecedente de EPOC en tratamiento con broncodilatadores inhalados y bromhexina 8mg cada 8h, más consumo de alcohol de una botella de vino de 750 cc durante los fines de semana, consulta por dificultades para caminar y hablar de 3 meses de evolución, progresivas, asociadas a torpeza de las extremidades. No ha presentado náuseas ni cefalea. Al examen Fsico, se aprecia ataxia de la marcha, habla disártrica y dismetría de las extremidades superiores, con imposibilidad de realizar movimientos alternantes de forma coordinada. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Toxicidad cerebelosa por bromhexina
B) Degeneración cerebelosa alcohólica
C) Esclerosis múl2ple
D) Síndrome paraneoplásico
E) Tumor cerebeloso

PREGUNTA 25 1.10.1.019

25. Una paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con an8inflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea más intensa de lo habitual, desde hace dos meses, que inicialmente era mayor durante la mañana, pero que ha aumentado en intensidad durante todo el día y se ha asociado a náuseas y vómitos explosivos. Refiere no haber tenido respuesta a pesar del uso frecuente de analgésicos y ergotamínicos. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de hipertensión endocraneana
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Encefalopaaa hipertensiva
D) Tumor cerebral
E) Cefalea por ergotamínicos

PREGUNTA 26 1.10.1.021

26. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis) · 1.10.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis). El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 27 1.10.1.022

27. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes convulsivos sintomáticos · 1.10.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes convulsivos sintomáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 28 1.10.1.023

28. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes sensitivos · 1.10.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes sensitivos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 29 1.10.1.024

29. Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, consulta por vér8go intenso de inicio súbito hace 2 horas, asociado a dificultades en la marcha que le impiden mantenerse de pie. Al examen Fsico se observa hipotónico, con dismetría de extremidades y nistagmus mul8direccional. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar difenidol
B) Realizar examen de VIII par
C) Solicitar prueba calórica
D) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de troncoencéfalo
E) Solicitar TAC de cerebro

PREGUNTA 30 1.10.2.014

30. Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea de 3 días de evolución, a lo que se le ha agregado desorientación y confusión. Además, ha presentado algunas convulsiones clónicas. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 células por mm3, con 90% mononucleares, con 15 glóbulos rojos por mm3, glucosa: 80 mg/dl, proteínas: 40 mg/dl; glicemia: 100 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Toxoplasmosis cerebral
B) Meningoencefalitis herpética
C) Tumor cerebral
D) Meningitis viral
E) Meningitis bacteriana aguda

PREGUNTA 31 1.10.1.013

31. Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que compromete la arcada dentaria superior y la encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además presenta dolor retro ocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intenso EVA 10/10, que se al tacto y al realizar actividades, como cepillarse los dientes e incluso una suave brisa puede desencadenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este cuadro?

A) Pregabalina
B) Tramadol
C) Prednisona
D) Paracetamol y AINEs
E) Amoxicilina

PREGUNTA 32 1.10.2.012

32. [URGENCIA: Síndrome cuadraplégico agudo · 1.10.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Síndrome cuadraplégico agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 33 1.10.1.007

33. Un niño de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además, refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Suspender por completo los videojuegos
B) Ácido valproico
C) Carbamazepina
D) Melatonina en la noche
E) Diazepam si convulsiona nuevamente

PREGUNTA 34 1.10.2.010

34. [URGENCIA: Movimientos anormales inducidos por fármacos · 1.10.2.010] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Movimientos anormales inducidos por fármacos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 35 1.10.2.018

35. Usted evalúa a un recién nacido, diagnosticado de asfixia, con una encefalopatía hipóxica, cae en estatus epiléptico. ¿Qué fármaco debe administrar?

A) Lidocaína
B) Barbitúricos
C) Sulfato de magnesio
D) Fenitoína
E) Lamotrigina

PREGUNTA 36 1.10.2.019

36. [URGENCIA: Status migrañoso · 1.10.2.019] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Status migrañoso. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

BLOQUE 3 TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

PREGUNTA 37 1.10.1.004

37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores · 1.10.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.10.1.028

38. Una mujer de 55 años consulta por cefalea progresiva, de localización interciliar y occipital, asociada a alteraciones visuales. Al examen físico, tiene hemianopsia heterónima, sin alteraciones motoras ni de la sensibilidad. ¿En qué estructura anatómica se encuentra con mayor probabilidad la lesión?

A) En las retinas
B) En ambos nervios ópticos
C) En el lóbulo occipital
D) En la radiación óptica
E) En el quiasma óptimo

PREGUNTA 39 1.10.1.029

39. Un niño de 6 años presenta múltiples en el tronco, que se muestran en la imagen. Su padre tiene lesiones similares. INSERTAR FOTO El diagnóstico más probable es:

A) Neurofibromatosis tipo 1
B) Enfermedad de Addison
C) Enfermedad celiaca
D) Síndrome de Peutz-Jeghers
E) Hiperplasia suprarrenal congénita

PREGUNTA 40 1.10.1.006

40. **Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha asociado a dificultades para iniciar la marcha. Relata que se había caído hacia adelante, en dos oportunidades, al empezar a caminar. Al inicio de la marcha es lento e inseguro, pero luego alcanza una velocidad normal, la que se mantiene por el resto del tiempo. No presenta disminución de las fuerzas de las extremidades y sus reflejos osteotendíneos son normales, al igual que la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:**

A) Enfermedad de Parkinson
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Polineuropatía diabética
D) Polimialgia reumática
E) Miopatía por cuerpos de inclusión

PREGUNTA 41 1.10.1.006

41. **El temblor de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por:**

A) Ser postural
B) Asociarse a aumento del pestañeo
C) Ser de intención
D) Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos
E) Asociarse a una marcha con aumento de la base de sustentación y pasos largos

PREGUNTA 42 1.10.1.006

42. **¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedada de Parkinson idiopática?:**

A) Demencia al inicio
B) Mioclonías.
C) Blefaroespasmo.
D) Retrocollis.
E) Pérdida de movimientos asociados en la marcha.

PREGUNTA 43 1.10.1.006

43. **¿Cuál de los siguientes medicamentos produce parkinsonismo por drogas con más frecuencia?**

A) Clozapina
B) Risperidona
C) Carbamacepina
D) Ergotamina
E) Amitriptilina

PREGUNTA 44 1.10.1.006

44. **Una paciente de 22 años consulta por presentar desde una semana antes ptosis palpebral izquierda, sin dolor, con diplopía en al mirada lateral izquierda. En la exploración física se comla existencia de una ptosis izquierda, una paresia de la abducción del ojo izquierdo, con unas pupilas isocóricas y normorreactivas de la luz. ¿Qué enfermedad es más probable que padezca la paciente?:**

A) Una neuritis óptica izquierda en relación con Esclerosis Múltiple.
B) Un síndrome de Horner.
C) Una Miastenia gravis.
D) Una parálisis del III par izquierdo.
E) Una miopatía hipertiroidea con afectación de la musculatura extraocular.

PREGUNTA 45 1.10.1.027

45. **Hombre de 65 años con antecedente de enfermedad de Parkinson. Su pareja refiere que durante el sueño emite gritos, golpea y patea. El paciente no recuerda nada al despertar. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Trastorno de conducta del sueño REM (RBD)
B) Sonambulismo
C) Terrores nocturnos
D) Apnea obstructiva del sueño
E) Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

PREGUNTA 46 1.10.1.006

46. **Está usted evaluando unadiagnóstica y finalmente se encuentra en la siguiente tabla: Enfermedad SÏ NO Prueba Positiva 80 100 Prueba Negativa 20 800 A partir de ella y redondeando decimales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:**

A) El valor predictivo positivo es del 56% y el valor predictivo negativo del 13%.
B) El valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%.
C) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 90%.
D) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 11%.
E) El valor predictivo positivo es del 10% y el valor predictivo negativo del 20%.

PREGUNTA 47 1.10.1.006

47. **Para determinar la relevancia de una enfermedad infecciosa grave conviene ocupar:**

A) Mortalidad general
B) Mortalidad específica
C) Incidencia
D) Prevalencia
E) Tasa de ataque

PREGUNTA 48 1.10.1.026

48. **Un paciente de 72 años consulta por temblor ambas extremidades, que aparece al realizar sus actividades habituales. Al examen físico se observa el mencionado temblor, sin otras alteraciones en la exploración neurológica. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de sus síntomas?**

A) Diazepam
B) Alprazolam
C) Propranolol
D) Levodopa
E) Sertralina

PREGUNTA 49 1.10.1.026

49. Un paciente de 72 años presenta temblor de las extremidades superiores, mayor a la izquierda. El temblor aumenta al adoptar una postura. Además se observa temblor del mentón y de la cabeza y el resto del examen neurológico es normal. El tratamiento de la patología descrita es:

A) Antagonistas dopaminérgicos
B) Agonistas dopaminérgicos
C) Betabloqueoygeriatria/ 1/9
D) Antipsicóticos
E) Anticonvulsivantes

PREGUNTA 50 1.10.1.026

50. Un paciente de 67 años consulta por temblor de las extremidades superiores, que aumenta al adoptar alguna postura. Refiere que su madre presentó un cuadro similar. La marcha y la coordinación motora son normales y no presenta focalidad en el examen neurológico. El tratamiento de la patología descrita es:

A) Antidepresivos tricíclicos
B) Agonistas dopaminérgicos
C) Betabloqueo
D) Antipsicóticos
E) Anticonvulsivantes

PREGUNTA 51 1.10.2.011

51. [URGENCIA: Paraplejia aguda · 1.10.2.011] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paraplejia aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 52 1.10.1.005

52. Paciente con 1 año de alucinaciones visuales, pérdida de memoria progresiva, rigidez, hipocinesia y alteración de la marcha. ¿Diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Parkinson con demencia
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Demencia frontotemporal
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Parálisis supranuclear progresiva

PREGUNTA 53 1.10.1.005

53. ¿Qué medicamento se utiliza para el manejo inicial del paciente con enfermedad de Alzheimer leve a moderada?

A) Benzodiacepinas.
B) Neurolépticos atípicos.
C) Inhibidores de la monoaminooxidasa.
D) Antidepresivos tipo ISRS.
E) Inhibidores de la acetilcolinesterasa.

PREGUNTA 54 1.10.2.020

54. [URGENCIA: Traumatismo encéfalo craneano leve · 1.10.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo encéfalo craneano leve. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

BLOQUE 4 PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

PREGUNTA 55 1.10.1.009

55. **Una mujer de 64 años consulta por dolor intercostal intenso de 3 semanas de evolución, que fue antecedido por la aparición de lesiones vesiculares en esa zona. En el examen físico se observa curación de las lesiones, algunas de las que dejaron cicatrices, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo del dolor?**

A) Pregabalina
B) Galantamina
C) Amitriptilina
D) Carbamazepina
E) Fluoxetina

PREGUNTA 56 1.10.1.010

56. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbago mecánico · 1.10.1.010] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbago mecánico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 57 1.10.1.011

57. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbociáticas y cervicobraquialgias. · 1.10.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbociáticas y cervicobraquialgias.. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 1.10.1.017

58. **Un paciente de 69 años presenta debilidad de las manos, asociados a disminución de la sensibilidad de manos y pies. Refiere además dolor tipo ardor en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad "en calcetín", signo de Lasegue negativo y presenta abolición de ambos reflejos aquileanos. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Radiculopatía S1
C) Síndrome de cola de caballo
D) Polineuropatía
E) Esclerosis lateral amiotrófica

PREGUNTA 59 1.10.2.013

59. **Un paciente de 29 años consulta por un cuadro de 7 días, progresivo, de disminución de la fuerza muscular, tanto en las extremidades superiores, como en las inferiores, siendo mayor en las inferiores. Tiene el antecedente de haber sufrido una influenza hace 14 días. Al examen físico tiene arreflexia aquiliana bilateral, asociada a hiporreflexia rotuliana mayor a derecha, con paresia M4 en las extremidades superiores y M3 en las inferiores. El diagnóstico más probable es:**

A) Radiculopatía S1 derecho
B) Polineuropatía desmielinizante aguda
C) Meningitis viral
D) Mielopatía por influenza
E) Miositis viral

PREGUNTA 60 1.10.2.013

60. **¿Qué es lo más constante en el examen físico de un paciente con una síndrome de Guillain-Barré?**

A) Arreflexia
B) Hipoventilación
C) Compromiso de conciencia
D) Hipoestesia
E) Oftalmoplejia

PREGUNTA 61 1.10.2.013

61. **Un paciente de 34 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia debilidad progresiva para caminar y para mover las manos. Al examen físico se aprecia además parálisis fácil y arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Miastenia gravis
C) Polineuropatía
D) Botulismo
E) Intoxicación por marea roja

PREGUNTA 62 1.10.2.013

62. Un adolescente de 16 años inicia un cuadro relativamente rápido de debilidad de las extremidades inferiores, que luego se extiende a las superiores, en cosa de 5 horas, agravándose a medida que pasa el tiempo. Al examen físico además se constata arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:

A) Polineuropatía
B) Síndrome de Guillain- Barre
C) Síndrome de compresión medular
D) Esclerosis múltiple
E) Miastenia gravis

PREGUNTA 63 1.10.2.013

63. Un paciente de 36 años presenta disestesias en las piernas, asociadas a debilidad progresiva, que a las 48 horas de su inicio le impide la marcha. Al examen se aprecia arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:

A) Polirradiculoneuritis desmielinizante
B) Síndrome de arteria espinal posterior
C) Mononeuritis múltiple
D) Polineuropatía
E) Esclerosis múltiple

PREGUNTA 64 1.10.1.020

64. Una paciente de 38 años, profesora de enseñanza básica, consulta por debilidad y mialgias generalizadas, que iniciaron hace un mes. Además, refiere ptosis a derecha, que suele ser mayor en las tardes. Al examen físico se constata ptosis bilateral, mayor a derecha, con normalidad de los reflejos osteotendíneos y la sensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esclerosis lateal amiotrófica
B) Polimiositis
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Esclerosis múltiple
E) Miastenia gravis

PREGUNTA 65 1.10.1.020

65. Lo más característico de la miastenia gravis es:

A) Debilidad de instalación súbita de un hemicuerpo
B) Debilidad proximal, asociada a elevación de la creatinfosfoquinasa (CK)
C) Debilidad distal asimétrica que mejora con el ejercicio
D) Debilidad proximal y distal simétricas, sin compromiso ocular
E) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante

PREGUNTA 66 1.10.1.020

66. Mujer de 33 años, consulta por astenia y diplopía, de 2 semanas de evolución, fluctuantes. Al examen se observa ptosis izquierda y ligero estrabismo divergente, que ella refiere no haber tenido previamente. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillan Barré7
B) Miastenia gravis
C) Tumor hipofisiario
D) Encefalopatía de Wernicke
E) Síndrome de Claude Bernard Horner

PREGUNTA 67 1.10.1.020

67. Una mujer de 33 años consulta por astenia y debilidad fluctuantes, asociadas a diplopía, que se agrava al realizar deporte. El diagnóstico de sospecha es:

A) Botulismo
B) Polineuropatía
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Miastenia gravis
E) Esclerosis múltiple

PREGUNTA 68 1.10.1.008

68. Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace un año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. El diagnóstico más probable es:

A) Polineuropatía por déficit de vitamina B12
B) Síndrome de Guillain Barré de presentación atípica
C) Infarto talámico
D) Esclerosis múltiple
E) Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

PREGUNTA 69 1.10.1.014

69. Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en ambas manos, de predominio nocturno, que disminuyen con el movimiento y ceden al iniciar sus actividades diarias. El examen físico muestra movilidad y sensibilidad conservadas, con leve atrofia de la eminencia tenar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neuropatía diabética simétrica sensitiva
B) Contractura de Dupuytren
C) Atrapamiento de los dedos flexores de la mano
D) Artritis reumatoide
E) Síndrome del túnel carpiano

PREGUNTA 70 1.10.1.015

70. Un hombre de 58 años presenta un cuadro de 3 años de evolución de debilidad progresiva de las extremidades, que trae problemas para caminar, hasta no poder hacerlo, a lo que luego se agrega dificultad para tragar. Evoluciona finalmente con dificultad respiratoria y necesidad de traqueostomía. No tiene alteración sensitiva. Se solicita espirometría que se muestra a continuación ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polineuropatía diabética
B) Distrofia muscular
C) Esclerosis múltiple
E) Esclerosis lateral amiotrófica
E) Hemograma y VHS

PREGUNTA 71 1.10.1.016

71. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el examen físico orientan más a una parálisis facial periférica derecha?

A) Mantener la capacidad de arrugar la frente y cerrar el ojo derecho
B) Compromiso de músculos masticatorios derechos
C) Presencia de hemiparesia braquiocrural derecha
D) Presencia de hemihipoestesia facial derecha
E) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón

PREGUNTA 72 1.10.1.025

72. Un paciente consulta porque hoy al despertar presentó vértigo muy intenso, que inició en el momento en que se levantó de la cama. El vértigo dura algunos segundos y se desencadena con los movimientos de la cabeza. No ha presentado síntomas auditivos. Al examen destaca nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Meniere
B) Vértigo postural paroxístico benigno
C) Neuronitis vestibular
D) Laberintitis aguda
E) Infarto de cerebelo

BLOQUE 5 GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

PREGUNTA 73 1.10.1.002

73. [ATENCIÓN PRIMARIA: Compromiso de conciencia · 1.10.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Compromiso de conciencia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.10.2.006

74. Una paciente de 20 años es encontrada inconsciente en el baño por sus familiares, con el piloto del calefont apagado, por lo que es llevada al servicio de urgencia de inmediato, recuperándose parcialmente en el camino. Al examen físico está consciente, responde al interrogatorio y coopera, aunque está soporosa y se queja de muchas náuseas y cefalea intensa. Satura 97% a FiO2 ambiental, tiene frecuencia cardíaca de 90x' y presión arterial 146/92 mmHg. Su examen cardiopulmonar resulta normal. Cuál es el examen de elección para

A) Radiografía de tórax
B) Resonancia magnética nuclear de cerebro
C) Carboxihemoglobina
D) Gases en sangre arterial
E) TAC de cerebro sin contraste

PREGUNTA 75 1.07.2.005

75. El síndrome confusional agudo se manifiesta clínicamente como:

A) Compromiso de conciencia cualitativo, asociado a signos focales, de inicio agudo yygeriatria/ 5/10 curso fluctuante
B) Pérdida de la memoria de corto y largo plazo, asociado a compromiso de consciencia de inicio agudo
C) Desorientación, imposibilidad de mantener la atención, compromiso de conciencia y alucinaciones, de inicio agudo
D) Agitación psicomotora y alucinaciones visuales, sin compromiso de consciencia, de inicio agudo
E) Ideas paranoides, fallas en la memoria de largo plazo y compromiso de consciencia de inicio agudo

PREGUNTA 76 1.07.2.005

76. El síndrome delirium se manifiesta clínicamente como:

A) Inatención y compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo de inicio agudo
B) Pérdida de la memoria de corto plazo y alucinaciones auditivas de inicio agudo
C) Desorientación y asterixis de instalación progresiva
D) Agitación psicomotora y convulsiones de inicio agudo
E) Ideas paranoides y fallas en la memoria de instalación progresiva

PREGUNTA 77 1.07.2.005

77. El tratamiento de elección del delirium tremens es:

A) Haldol
B) Diazepam
C) Etanol
D) Risperidona
E) Clorpromazina

PREGUNTA 78 1.07.2.005

78. Paciente hombre de 75 años, autovalente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y pérdida leve de memoria desde hace 3 a 4 años. Hace una semana lo notan apático y con comportamiento extraño. Hace tres días, salió de compras y un vecino debió traerlo a casa pues no recordaba el camino. Desde hace dos días habla incoherencias, se agita y presenta insomnio. El diagnóstico más probable es::

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Demencia por cuerpos de Lewy
C) Trastorno psicótico
D) Demencia frontotemporal
E) Delirium

PREGUNTA 79 1.07.2.005

79. En el enfrentamiento clínico sistemático de Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 80 1.07.2.005

80. En el enfrentamiento clínico sistemático de Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 81 1.07.1.008

81. Una mujer de 55 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T- score de -2,3 DS y un Z-score de -1 DS. El diagnóstico más probable es:

A) Sano
B) Osteopenia
C) Osteoporosis primaria
D) Osteoporosis secundaria
E) Osteopetrosis

PREGUNTA 82 1.07.1.008

82. ¿Por qué mecanismo se produce la mayor parte de las fracturas de cadera?

A) Caídas a nivel
B) Caídas de altura
C) Rotación forzada
D) Fractura espontánea durante la marcha normal
E) Accidentes de tránsito

PREGUNTA 83 1.07.1.008

83. En el enfrentamiento clínico sistemático de Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 84 1.07.1.008

84. En el enfrentamiento clínico sistemático de Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 85 1.07.1.001

85. ¿Cuál es la presentación clínica más habitual de las fracturas de cadera?

A) Acortamiento, rotación interna y aducción del muslo, con imposibilidad de caminar
B) Acortamiento, rotación externa y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
C) Acortamiento, rotación interna y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
D) Posición púdica, equimosis, crujido articular y dolor intenso durante la marcha
E) Posición impúdica, aumento de volumen y dolor intenso durante la marcha

PREGUNTA 86 1.07.1.001

86. ¿Cuál de los siguientes fármacos se asocian a un mayor riesgo de caídas en el paciente anciano?:

A) Atenolol
B) Aspirina
C) Atorvastatina
D) Amoxicilina
E) Metformina

PREGUNTA 87 1.07.1.001

87. En el enfrentamiento clínico sistemático de Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) Más del 90% de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a nivel desde su propia altura sobre hueso osteoporótico.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 88 1.07.3.007

88. ¿Cuál de las siguientes lesiones oculares no requieren manejo estricto por especialista?

A) Trauma ocular con discoria
B) Trauma ocular con hemorragia subconjuntival
C) Trauma ocular con herida palpebral, que compromete el borde libre
D) Trauma ocular con herida palpebral transfixiante
E) Trauma ocular con amaurosis

PREGUNTA 89 1.07.3.007

89. Una paciente de 40 años, consulta por incontinencia urinaria, caracterizada por deseos incontrolables de orinar, que no le permiten llegar al baño, orinándose completamente. Se solicita urocultivo y sedimento de orina que resultan normales y se indican ejercicios y medidas conductuales, las que no muestran mayores beneficios. El tratamiento más adecuado es:

A) Quirúrgico
B) Iniciar bloqueadores alfa-adrenérgicos
C) Iniciar anticolinérgicos
D) Iniciar betabloqueo
E) Iniciar agonistas dopaminérgicos

PREGUNTA 90 1.07.3.007

90. En el enfrentamiento clínico sistemático de Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) La polifarmacia (≥ 5 fármacos) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa corporal, declive renal) multiplican el riesgo de RAM y caídas.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

Hipertensión endocraneana

1.10.2.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hipertensión endocraneana" como urgencia clínica (1.10.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 2 Respuesta: B

Traumatismo encefalocraneano grave

1.10.2.021 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: No requiere

Es un hematoma epidural clásico, tanto por la fractura, como por la clínica de HTEC grave, como por el breve intervalo lúcido.

PREGUNTA 3 Respuesta: C

Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

1.10.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la C (Realizar endarterectomía derecha). La razón principal radica en la presencia de una estenosis carotídea significativa (60%) en el lado derecho, en un paciente que ha sufrido un AVE isquémico reciente. * **Estenosis Carotídea Sintomática:** La estenosis carotídea se considera sintomática porque el paciente ya tuvo un evento isquémico (AVE). Las guías internacionales y la evidencia disponible indican que la endarterectomía carotídea (o en algunos casos, la angioplastia con stent) es beneficiosa en pacientes sintomáticos con estenosis entre 50-99% (según algunas guías, el umbral puede ser 70% en otras). El objetivo es reducir el riesgo de un nuevo evento isquémico. * **Oportunidad:** El paciente fue manejado oportunamente con trombólisis, lo cual sugiere que se encuentra en una ventana de tiempo en la que la intervención quirúrgica carotídea puede ser realizada de forma segura y efectiva para prevenir futuros eventos. * **Lado Afectado:** La estenosis del 60% en el lado derecho es la más significativa y, por lo tanto, la que requiere intervención. Aunque existe una estenosis del 40% en el lado izquierdo, esta no alcanza el umbral para la intervención quirúrgica en un paciente sintomático, al menos no de forma inmediata. **Importante:** Si bien no contamos con una guía clínica MINSAL específica para el manejo de la estenosis carotídea sintomática post-AVE, la evidencia internacional (como las guías de la American Heart Association/American Stroke Association) son consistentes en recomendar la intervención en estenosis significativas en pacientes sintomáticos. El juicio clínico y la discusión del caso con un equipo multidisciplinario (neurólogo, cirujano vascular) son fundamentales.

PREGUNTA 4 **Respuesta: C**

Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

1.10.2.001, 1.10.2.007

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La alternativa correcta es la C (Realizar endarterectomía derecha). La razón principal radica en la presencia de una estenosis carotídea significativa (60%) en el lado derecho, en un paciente que ha sufrido un AVE isquémico reciente. * **Estenosis Carotídea Sintomática:** La estenosis carotídea se considera sintomática porque el paciente ya tuvo un evento isquémico (AVE). Las guías internacionales y la evidencia disponible indican que la endarterectomía carotídea (o en algunos casos, la angioplastia con stent) es beneficiosa en pacientes sintomáticos con estenosis entre 50-99% (según algunas guías, el umbral puede ser 70% en otras). El objetivo es reducir el riesgo de un nuevo evento isquémico. * **Oportunidad:** El paciente fue manejado oportunamente con trombólisis, lo cual sugiere que se encuentra en una ventana de tiempo en la que la intervención quirúrgica carotídea puede ser realizada de forma segura y efectiva para prevenir futuros eventos. * **Lado Afectado:** La estenosis del 60% en el lado derecho es la más significativa y, por lo tanto, la que requiere intervención. Aunque existe una estenosis del 40% en el lado izquierdo, esta no alcanza el umbral para la intervención quirúrgica en un paciente sintomático, al menos no de forma inmediata. **Importante:** Si bien no contamos con una guía clínica MINSAL específica para el manejo de la estenosis carotídea sintomática post-AVE, la evidencia internacional (como las guías de la American Heart Association/American Stroke Association) son consistentes en recomendar la intervención en estenosis significativas en pacientes sintomáticos. El juicio clínico y la discusión del caso con un equipo multidisciplinario (neurólogo, cirujano vascular) son fundamentales.

PREGUNTA 5 **Respuesta: C**

Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

1.10.2.001, 1.10.2.007

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

El paciente presenta un cuadro compatible con un accidente isquémico transitorio (AIT) o un infarto cerebral menor con recuperación espontánea temprana. La aparición súbita de déficit neurológico focal (hemiparesia derecha y afasia), la duración breve (30 minutos) y la recuperación completa antes de las 48 horas (en este caso, al segundo día), sin evidencia de hemorragia en la TAC inicial, son características clave. Un AIT es un evento isquémico cerebral que causa síntomas neurológicos transitorios sin evidencia de infarto agudo en las pruebas de imagen. Sin embargo, clínicamente, el abordaje diagnóstico y la urgencia son idénticos a los de un ACV isquémico, ya que un AIT es un fuerte predictor de un ACV inminente. La conducta más adecuada es buscar la etiología subyacente de este evento isquémico para implementar medidas de prevención secundaria específicas y efectivas. Las causas más comunes de AIT/ACV isquémico incluyen: enfermedad aterosclerótica de grandes vasos (especialmente carotídea), fuentes cardioembólicas (como fibrilación auricular, enfermedad valvular, foramen oval permeable, trombos intracavitarios) y enfermedad de pequeños vasos. La solicitud de un Holter de arritmias busca detectar fibrilación auricular paroxística; el ecocardiograma evalúa el corazón como posible fuente de émbolos (válvulas, función ventricular, trombos, foramen oval); y el eco-doppler carotídeo evalúa la presencia de estenosis carotídea significativa, una causa tratable de ACV. Identificar la causa permitirá instaurar el tratamiento más adecuado (por ejemplo, anticoagulación para fibrilación auricular, endarterectomía o stenting para estenosis carotídea severa).

PREGUNTA 6 **Respuesta: A**

Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

1.10.2.001, 1.10.2.007

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La alternativa correcta es solicitar un TAC de cerebro sin contraste debido a la sospecha clínica de un accidente cerebrovascular (ACV) agudo. El paciente presenta una hemiparesia izquierda de inicio súbito, acompañada de hemihipoestesia ipsilateral, lo cual sugiere fuertemente un evento isquémico o hemorrágico en el hemisferio derecho. El TAC de cerebro sin contraste es el estudio de neuroimagen de primera línea para diferenciar entre un ACV isquémico y uno hemorrágico. Esta diferenciación es crucial porque el tratamiento para cada uno es completamente distinto. En el ACV isquémico, se considera la trombolisis o trombectomía mecánica, mientras que en el ACV hemorrágico, estos tratamientos están contraindicados. La rapidez en la obtención del TAC es fundamental para determinar la elegibilidad del paciente para terapias de reperfusión en caso de ACV isquémico. Las Guías Clínicas MINSAL para el manejo del ACV isquémico establecen que la neuroimagen debe obtenerse idealmente dentro de los primeros 25 minutos desde el arribo del paciente al servicio de urgencias.

PREGUNTA 7 **Respuesta: E**

Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

1.10.2.001, 1.10.2.007 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Estamos ante un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico (ACV isquémico) agudo. Los síntomas (afasia y hemiparesia) comenzaron hace solo 1 hora, y la TAC inicial no muestra hemorragia. Esto es crucial, ya que la ausencia de hemorragia en la TAC es un criterio de inclusión para la trombolisis con activador tisular del plasminógeno (tPA). El tiempo es cerebro, y cada minuto cuenta en estos casos. La trombolisis es el tratamiento de elección en la fase aguda del ACV isquémico, dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas (y hasta 3 horas en algunos centros, aunque la ventana se está expandiendo). El objetivo es restaurar el flujo sanguíneo al área cerebral afectada y minimizar el daño. La guía clínica del MINSAL para el manejo del ACV isquémico enfatiza la importancia del reconocimiento temprano de los síntomas y la rápida administración de tPA en pacientes elegibles. El paciente cumple con los criterios de inclusión para la trombolisis: déficit neurológico agudo, inicio de los síntomas dentro de la ventana terapéutica y ausencia de hemorragia en la TAC.

PREGUNTA 8 **Respuesta: E**

Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

1.10.2.007 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene un AVE diagnosticado (se diagnostica con la clínica de signos focales de inicio súbito). La TAC se pide solo para diferenciar los AVE hemorrágicos, de los isquémicos y, en este caso, por estar normal la TAC se confirma que no es hemorrágico, sino isquémico. Por tener menos de 4,5 horas de evolución, está dentro de la ventana de trombolíticos, que es lo más urgente (rTPA ev).

PREGUNTA 9 **Respuesta: A**

Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

1.10.2.002 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La paciente presenta una fibrilación auricular (FA) con múltiples factores de riesgo tromboembólico, evidenciados por su antecedente de ACV isquémico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, edad (68 años) y sexo femenino. Esto le confiere un puntaje CHA2DS2-VASc muy elevado (7 puntos: 1 por HTA, 1 por DM2, 2 por ACV previo, 1 por enfermedad vascular, 1 por edad 65-74, 1 por sexo femenino), lo que indica un riesgo muy alto de eventos cerebrovasculares isquémicos. El hecho de haber sufrido un ataque isquémico transitorio (AIT) mientras recibía aspirina, sumado a la FA crónica y una aurícula izquierda aumentada de tamaño, refuerza la insuficiencia de la terapia antiplaquetaria para la prevención de tromboembolismos de origen cardioembólico. La guía actual para pacientes con FA de alto riesgo como esta, recomienda encarecidamente la anticoagulación oral para la prevención de eventos tromboembólicos. Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, o los anticoagulantes orales directos (DOACs), son significativamente más efectivos que la aspirina o la terapia antiplaquetaria dual en la prevención de eventos cardioembólicos. La opción A propone iniciar acenocumarol, un anticoagulante oral, lo cual es la estrategia más apropiada y basada en la evidencia para esta paciente. La mención de "terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular" es consistente con la práctica clínica, donde a menudo se utiliza heparina como puente para lograr una anticoagulación rápida mientras el acenocumarol alcanza su nivel terapéutico, especialmente en un contexto de un evento agudo como un AIT.

PREGUNTA 10 **Respuesta: E**

Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

1.10.2.002 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La respuesta correcta es (e) debido a que el paciente presenta un Ataque Isquémico Transitorio (AIT) de alto riesgo. Un AIT se define como un episodio transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral, medular o retiniana, sin infarto agudo. En este caso, la sintomatología (afasia y hemiparesia derecha) es altamente sugestiva de isquemia cerebral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, y la resolución espontánea en 30 minutos cumple con la definición de AIT. El factor de riesgo crucial es la Fibrilación Auricular Crónica (ACxFA), la causa más frecuente de accidente cerebrovascular cardioembólico. A pesar de estar en tratamiento con aspirina, la aparición de un AIT con ACxFA indica un fracaso de la profilaxis antiplaquetaria y una necesidad urgente de cambiar a anticoagulación. La hospitalización es imperativa en pacientes con AIT de alto riesgo, como aquellos con fibrilación auricular, para una evaluación rápida y exhaustiva y para iniciar la prevención secundaria de forma inmediata. El riesgo de un accidente cerebrovascular (ACV) después de un AIT es máximo en las primeras horas a días. La resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro con secuencia de difusión (DWI) es el estudio de imagen más sensible para detectar isquemia aguda, incluso en casos donde la TAC cerebral puede ser normal. Iniciar anticoagulación con heparina (ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular) es la medida más adecuada para prevenir un evento isquémico recurrente en un paciente con AIT de origen cardioembólico por ACxFA, proporcionando un efecto anticoagulante rápido mientras se espera la estratificación y el inicio de la anticoagulación oral a largo plazo. Las "medidas de neuroprotección" en este contexto se refieren a un manejo integral para optimizar el pronóstico, incluyendo el control estricto de factores de riesgo como la presión arterial, la glucemia y el manejo de lípidos, además de la anticoagulación efectiva para prevenir un ACV establecido.

PREGUNTA 11 **Respuesta: C**

Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos 1.10.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hematoma subdural crónico en adulto mayor: cefalea crónica + ataxia + deterioro cognitivo + colección hipodensa (crónica >3 semanas) entre córtex y cráneo en TAC = hematoma subdural crónico. Frecuentemente sin traumatismo recordado. Tratamiento: trépano de drenaje si sintomático.

PREGUNTA 12 **Respuesta: B**

Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos 1.10.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 166). Evalúa el manejo clínico de Crisis convulsiva según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 13 **Respuesta: D**

Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos 1.10.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El caso clínico describe un paciente pediátrico con un síndrome meníngeo clásico (cefalea, fiebre, rigidez de nuca). La clave para el diagnóstico diferencial se encuentra en el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR). Las características del LCR del paciente son: 1. **Aspecto**: Claro, lo que sugiere una meningitis no purulenta. 2. **Celularidad**: 60 células/mm³, lo que indica una pleocitosis leve a moderada (lo normal es < 5 células). 3. **Predominio celular**: 99% de mononucleares (linfocitos). Este es el dato más importante, ya que una **pleocitosis a predominio linfocitario** es característica de meningitis virales, tuberculosas o fúngicas, y descarta una meningitis bacteriana típica. 4. **Proteínas**: 50 mg/dl. Ligeramente elevadas o en el límite alto de la normalidad (normal < 45 mg/dl), lo cual es compatible con una inflamación meníngea leve. 5. **Glucosa**: 60 mg/dl. Este valor se considera normal (**normoglucorraquia**), especialmente si se asume una glicemia sérica normal (aprox. 80-100 mg/dl), manteniendo una relación LCR/plasma > 0.6. La combinación de pleocitosis leve a predominio linfocitario, con proteínas levemente elevadas y glucosa normal, es el patrón clásico y más frecuente de una **meningitis viral** (también llamada meningitis aséptica). Los enterovirus son la causa más común en este grupo de edad.

PREGUNTA 14 **Respuesta: D**

Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos 1.10.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Este caso presenta a un paciente diabético mal controlado con un cuadro de neumonía grave que evoluciona a shock séptico (hipotensión, taquicardia, taquipnea, compromiso de conciencia). La probabilidad de una neumonía adquirida en la comunidad (NAC) complicada, con factores de riesgo para patógenos resistentes, es alta. El paciente cumple criterios de gravedad que obligan a hospitalización en UCI. El tratamiento empírico debe cubrir los patógenos más frecuentes, incluyendo *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus* (incluyendo considerar SARM en paciente con factores de riesgo), y *Legionella pneumophila*. Además, el paciente tiene diabetes, lo que lo hace más susceptible a infecciones por organismos atípicos. La guía GES Neumonía Adquirida en la Comunidad del MINSAL (2013, aunque está pendiente una actualización) recomienda para pacientes hospitalizados con neumonía grave, una combinación de un betalactámico de amplio espectro (como ceftriaxona o cefotaxima) más un macrólido (como claritromicina o azitromicina) o una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacino o moxifloxacino). El macrólido cubre *Legionella* y otros atípicos.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

1.10.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es **Hipovolemia con compromiso prerrenal**. El cuadro clínico se presenta en el contexto de un trauma con hipotensión, una causa clásica de hipoperfusión renal que lleva a una Insuficiencia Renal Aguda (IRA) de tipo prerrenal. En este estado, los riñones están estructuralmente sanos, pero el flujo sanguíneo que reciben es insuficiente para mantener una tasa de filtración glomerular (TFG) normal. La clave para confirmar el diagnóstico y diferenciarlo de un daño intrínseco (como la necrosis tubular aguda) son los índices urinarios. En este caso, el riñón, al detectar la hipovolemia, activa intensamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y agua, en un intento por restaurar el volumen circulante. Esto se traduce en una orina muy concentrada con una excreción de sodio extremadamente baja. Los valores del paciente son categóricos: un sodio urinario de 5mEq/l (típicamente <20 en prerrenal) y una Fracción Excretada de Sodio (FeNa) calculada de 0.5% ([(UNa x PCrea) / (PNa x UCrea)] x 100 = [(5 x 3.5) / (140 x 25)] x 100 = 0.5%). Un FeNa <1% es el sello distintivo de una causa prerrenal, ya que indica que la función tubular de reabsorción de sodio está intacta y ávida. Aunque la paciente ha comenzado a orinar y su presión ha mejorado, la creatinina sigue elevada porque la recuperación de la TFG puede ser más lenta que la restauración de la volemia y la diuresis.

PREGUNTA 16 **Respuesta: B**

Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

1.10.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción (b), "Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos", es la descripción más clásica y sugerente de una hemorragia subaracnoídea (HSA) por rotura de un aneurisma. La característica cardinal de la HSA es el "inicio súbito" de la cefalea, a menudo descrita como un "thunderclap headache" (cefalea en trueno), que alcanza su máxima intensidad en segundos o minutos. Esta aparición abrupta se debe a la extravasación repentina de sangre en el espacio subaracnoídeo, lo que provoca una irritación meníngea masiva y un rápido aumento de la presión intracraneal. La intensidad "10/10" o "la peor cefalea de mi vida" es prácticamente patognomónica de una HSA, reflejando el dolor extremo causado por la irritación de las meninges y el aumento agudo de la presión. Los vómitos son un síntoma acompañante muy común, resultado de la estimulación de los centros eméticos en el tronco encefálico debido al incremento de la presión intracraneal. Esta combinación de inicio explosivo, dolor insoportable y síntomas vegetativos como los vómitos, convierte a la opción (b) en la presentación clínica que con mayor precisión apunta a una emergencia neuroquirúrgica como la HSA por aneurisma roto.

PREGUNTA 17 **Respuesta: D**

Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

1.10.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene una angina crónica estable, por lo que se debe estudiar con un test de La...

PREGUNTA 18 **Respuesta: C**

Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena

1.10.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la c) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoagulante potenciando la acción de la antitrombina III, que inhibe principalmente la trombina y el factor Xa. El TTPA es el examen de laboratorio que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación, las cuales se ven afectadas por la acción de la HNF. El objetivo del control del TTPA es mantenerlo en un rango terapéutico, generalmente entre 1.5 y 2.5 veces el valor control, para asegurar una anticoagulación adecuada y minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. El TTPA permite monitorizar la respuesta individual del paciente a la HNF, ya que esta respuesta puede variar debido a factores como la edad, la función renal, el peso corporal y la presencia de otras enfermedades. La titulación de la dosis de HNF se realiza en base a los resultados del TTPA, buscando alcanzar el rango terapéutico definido.

BLOQUE 2 CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: A** urémico, etc)

1.10.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "urémico, etc)" como urgencia clínica (1.10.2.016), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A**

con meningitis purulenta o bacteriana

1.10.2.017 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "con meningitis purulenta o bacteriana" como urgencia clínica (1.10.2.017), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 21 **Respuesta: E**

Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

1.10.2.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Si bien es una pregunta rara, que tenga una lesión quística, más eosinófilos en el LCR hace que sea una neurocisticercosis por Taenia solium.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A**

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una cefalea tensional clásica (como la que da al salir del Eunacom).

PREGUNTA 23 **Respuesta: A**

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

1.10.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La pregunta aborda el tratamiento profiláctico de la migraña, es decir, medicamentos que se usan de forma regular para disminuir la frecuencia, intensidad y duración de los episodios de jaqueca. La respuesta correcta, Sumatriptán, es la excepción porque no se utiliza para este propósito. El Sumatriptán pertenece a la clase de los triptanos, que son agonistas selectivos de los receptores 5-HT1B/1D de serotonina. Su mecanismo de acción implica la vasoconstricción de los vasos sanguíneos craneales dilatados y la inhibición de la liberación de neuropéptidos proinflamatorios, lo que resulta en un alivio rápido del dolor y los síntomas asociados a un ataque agudo de migraña. Por lo tanto, el Sumatriptán es un tratamiento abortivo o agudo, diseñado para ser tomado al inicio de una crisis de migraña para detenerla, no para prevenir futuras crisis.

PREGUNTA 24 **Respuesta: D**

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

1.10.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Pregunta muy difícil, aunque Gene un claro síndrome cerebeloso. Sin embargo, no queda clara la causa. Tiene factores de riesgo para cáncer pulmonar, que puede producir una cerebeliGs autoinmune, siendo compaGble el cuadro con la velocidad que se instauró. No Gene náuseas ni cefalea para pensar en un tumor. El consumo de alcohol no es muy grande y el daño cerebeloso por alcohol suele ser de instalación mucho más lenta. La bromhexina no suele producir toxcicidad cerebelosa y, en caso de hacerlo, es muy raro. El ACV cerebeloso (no está en las opciones) suele instalarse de forma súbita. La esclerosis múlGple también se instala más rápido en algunos pocos días. En resumen, la velocidad con la que progresa hace pensar en una cerebeliGs autoinmune paraneoplásica.

PREGUNTA 25 **Respuesta: A**

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

1.10.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

El predominio maGnal y la presencia de náuseas y vómitos orienta a hipertensión endocraneana (HTEC). De hecho, el síndrome de HTEC completo es cefalea de predominio maGnal, náuseas / vómitos y edema de papila en el fondo de ojo. Por ello, se debe realizar un fondo de ojo y solicitar una neuroimagen.

PREGUNTA 26 **Respuesta: A**

1.10.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis)" (1.10.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 27 **Respuesta: A**

1.10.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes convulsivos sintomáticos" (1.10.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

1.10.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes sensitivos" (1.10.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 29 **Respuesta: E**

1.10.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

Tiene un vérGgo de Gpo central, por el nistagmo mulGdireccional y la dismetría (propio de los síndromes cerebelosos). Con ello, se debe solicitar una neuroimagen. Si bien la RMN ve mejor la fosa posterior y, probablemente, se solicite después, lo más urgente es la TAC de cerebro, ya que es un examen rápido y la primera sospecha es un ACV cerebeloso o del sistema vertebrobasilar, que está dentro de la ventana de trombólisis, en caso de que sea isquémico.

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

1.10.2.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

Es una encefalitis herpética clásica: anteraciones conductuales, convulsiones, compromiso de conciencia, líquido cefalorraquídeo compatible con meningitis viral, pero hemorrágico. Lo unico raro era la edad, ya que suele afectar a personas más jóvenes.

PREGUNTA 31 **Respuesta: D**

1.10.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo

Es una neuralgia del trigémino y de primera línea se dan carbamazepina u otros anticonvulsivantes, aunque también sirven los antidepresivos tricíclicos. De segunda línea, se puede agregar la pregabalina (lo habitual es CBZ y luego pregabalina).

PREGUNTA 32 **Respuesta: A**

Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo

1.10.2.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Síndrome cuadraplégico agudo" como urgencia clínica (1.10.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 33 **Respuesta: B**

Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES

1.10.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una epilepsia mioclónica. Los niños con epilepsia sí pueden ver pantallas, pero máximo 1 hora al día, con una buena iluminación.

PREGUNTA 34 **Respuesta: A**

Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES

1.10.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Movimientos anormales inducidos por fármacos" como urgencia clínica (1.10.2.010), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

1.10.2.018 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El estatus epiléptico en un recién nacido, especialmente en el contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) secundaria a asfixia, es una emergencia neurológica que requiere tratamiento inmediato para prevenir un mayor daño cerebral. El manejo de las convulsiones neonatales sigue un algoritmo escalonado. El fármaco de primera línea o, en su defecto, el segundo tras el fracaso de las benzodiacepinas (que no están en las opciones), es el **fenobarbital**, un tipo de **barbitúrico**. El fenobarbital es el anticonvulsivo más estudiado y utilizado en el período neonatal. Actúa potenciando la acción del neurotransmisor inhibidor GABA, lo que ayuda a suprimir la actividad eléctrica cerebral anómala y detener las convulsiones. Dada la gravedad del cuadro (estatus epiléptico) y las opciones disponibles, los barbitúricos son la elección correcta y estándar en la práctica clínica neonatal.

PREGUNTA 36 **Respuesta: A**

Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

1.10.2.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Status migrañoso" como urgencia clínica (1.10.2.019), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

BLOQUE 3 TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A**

Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores

1.10.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores" (1.10.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: E** **Tumores de región sellar** 1.10.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Tumor Hipofisario con Compromiso del Quiasma Óptico: La sospecha es un tumor hipofisario que afecta el quiasma óptico, causando hemianopsia heterónima bitemporal. La alteración del nervio óptico produce amaurosis, mientras que las lesiones del lóbulo occipital, radiaciones y cintilla óptica se manifiestan como hemianopsia homónima contralateral.

PREGUNTA 39 **Respuesta: A**

Tumores primarios y metastásicos SNC

1.10.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Eran manchas café con leche, que si son más de 6, se asocian a NF1.

PREGUNTA 40 **Respuesta: A**

Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

1.10.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es una anfermedad de Parkinson clásico: temblor de reposo, bradicinesia y problemas de inicio de marcha.

PREGUNTA 41 **Respuesta: D**

Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta, D) "Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos", describe de manera precisa el temblor característico de la enfermedad de Parkinson. Este es el síntoma motor cardinal más distintivo y a menudo el primero en manifestarse. Se conoce como temblor de reposo porque aparece cuando la extremidad (brazo, pierna o mano) está completamente relajada y apoyada, es decir, sin ninguna actividad muscular voluntaria ni sosteniéndose contra la gravedad. Típicamente, tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz y se describe comúnmente como un "signo de contar monedas" o "pill-rolling" por el movimiento repetitivo del pulgar y el índice. Una característica fundamental de este temblor es que disminuye o incluso desaparece por completo durante el movimiento voluntario o intencional de la extremidad afectada, y reaparece cuando la extremidad vuelve al reposo. También suele desaparecer durante el sueño. Aunque algunos pacientes pueden desarrollar un componente postural o cinético leve con el avance de la enfermedad, el temblor de reposo es el rasgo distintivo y el principal criterio semiológico para su diagnóstico diferencial con otros trastornos del movimiento. Su intensidad puede variar, exacerbándose con el estrés emocional o la fatiga.

PREGUNTA 42 **Respuesta: E**

Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La pérdida de movimientos asociados en la marcha, como la reducción o ausencia del braceo de los brazos, es uno de los signos motores cardinales y tempranos de la Enfermedad de Parkinson idiopática. Este fenómeno es una manifestación de la bradicinesia/acinesia, que es la lentitud o dificultad para iniciar y ejecutar el movimiento, y la pérdida de movimientos automáticos. En la marcha parkinsoniana típica, además de la postura encorvada y el arrastre de pies, es característico observar cómo los brazos no se balancean de forma rítmica y simétrica como lo harían en una persona sana, o incluso permanecen rígidamente pegados al cuerpo. Este hallazgo es muy frecuente porque se relaciona directamente con el déficit dopaminérgico en los ganglios basales que subyace a la patogenia de la enfermedad. La alteración en el circuito motor provoca una dificultad para la ejecución fluida y coordinada de movimientos automáticos y semi-automáticos, de los cuales el braceo es un excelente ejemplo. La asimetría en el braceo es, de hecho, uno de los signos tempranos que a menudo son notados por familiares o el propio paciente, incluso antes de que se establezca un diagnóstico formal. Por lo tanto, la pérdida de movimientos asociados en la marcha, especialmente el braceo, es un criterio diagnóstico clave y un hallazgo motor muy prevalente y característico en la Enfermedad de Parkinson idiopática, presente desde las etapas iniciales de la enfermedad en la mayoría de los pacientes.

PREGUNTA 43 **Respuesta: B**

Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la Risperidona. La Risperidona es un antipsicótico atípico que ejerce su efecto bloqueando los receptores de dopamina D2 en el sistema nervioso central, particularmente en los ganglios basales. Este bloqueo dopaminérgico, similar al que ocurre en la enfermedad de Parkinson idiopática, puede manifestarse clínicamente como parkinsonismo inducido por fármacos. Los síntomas suelen incluir bradicinesia (lentitud de movimiento), rigidez muscular, temblor en reposo y, en algunos casos, inestabilidad postural. La incidencia de parkinsonismo con la Risperidona es relativamente alta en comparación con otros antipsicóticos atípicos, aunque generalmente menor que con los antipsicóticos típicos de alta potencia. El riesgo de desarrollar parkinsonismo inducido por fármacos con Risperidona está relacionado con la dosis y la duración del tratamiento, así como con factores individuales del paciente como la edad y la presencia de otros trastornos neurológicos. Es importante destacar que, si bien la Clozapina (opción a) también es un antipsicótico atípico, tiene un riesgo significativamente menor de parkinsonismo, e incluso puede ser beneficiosa en algunos pacientes con Parkinson.

PREGUNTA 44 **Respuesta: C**

Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La presentación clínica de la paciente es altamente sugestiva de Miastenia gravis (MG), específicamente de la forma ocular. La Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular, resultando en debilidad muscular fluctuante. Los síntomas oculares son la manifestación inicial en la mayoría de los casos y se caracterizan por ptosis (caída del párpado) y diplopía (visión doble), que empeoran con la fatiga y mejoran con el reposo. En este caso, la paciente presenta ptosis palpebral izquierda y diplopía en la mirada lateral izquierda debido a paresia de la abducción del ojo izquierdo, lo que indica debilidad del músculo recto lateral izquierdo (inervado por el VI par craneal). Un hallazgo crucial que orienta fuertemente hacia la Miastenia gravis y permite descartar otras causas de oftalmoplejía es la normalidad de las pupilas (isocóricas y normorreactivas a la luz). La Miastenia gravis afecta únicamente la musculatura estriada voluntaria y nunca las fibras autonómicas que controlan la pupila, ya que estas últimas poseen receptores muscarínicos de acetilcolina que no son el blanco de los autoanticuerpos miasténicos. La edad joven de la paciente (22 años) y el curso subagudo de los síntomas ("desde una semana antes") también son consistentes con el perfil de la Miastenia gravis.

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

1.10.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Comportamientos violentos durante el sueño REM en paciente con Parkinson = trastorno de conducta del sueño REM (RBD). Es el parasomnia más frecuente en sinucleinopatías. El sujeto actúa sus sueños.

PREGUNTA 46 **Respuesta: B**

Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

1.10.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Para resolver esta pregunta, es fundamental comprender las definiciones y fórmulas del Valor Predictivo Positivo (VPP) y el Valor Predictivo Negativo (VPN), que son medidas de la utilidad de una prueba diagnóstica en la práctica clínica. Estas medidas dependen de la prevalencia de la enfermedad y se calculan a partir de los resultados de la prueba en individuos con y sin la enfermedad, como se presenta en la tabla de contingencia. La tabla proporcionada se interpreta de la siguiente manera: - Verdaderos Positivos (VP): Individuos con la enfermedad que dan positivo en la prueba. En este caso: 80. - Falsos Positivos (FP): Individuos sin la enfermedad que dan positivo en la prueba. En este caso: 100. - Falsos Negativos (FN): Individuos con la enfermedad que dan negativo en la prueba. En este caso: 20. - Verdaderos Negativos (VN): Individuos sin la enfermedad que dan negativo en la prueba. En este caso: 800. El Valor Predictivo Positivo (VPP) es la probabilidad de que un paciente que ha obtenido un resultado positivo en la prueba realmente tenga la enfermedad. Su fórmula es: VPP = VP / (VP + FP). Calculando el VPP: VPP = 80 / (80 + 100) = 80 / 180 = 0.4444... Redondeado a porcentaje: 44%. El Valor Predictivo Negativo (VPN) es la probabilidad de que un paciente que ha obtenido un resultado negativo en la prueba realmente no tenga la enfermedad. Su fórmula es: VPN = VN / (FN + VN). Calculando el VPN: VPN = 800 / (20 + 800) = 800 / 820 = 0.9756... Redondeado a porcentaje: 98%. Por lo tanto, la afirmación verdadera es que el valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%, lo que corresponde a la opción B.

PREGUNTA 47 **Respuesta: C**

1.10.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

La incidencia es la medida epidemiológica más adecuada para determinar la "relevancia" de una enfermedad infecciosa grave. Se define como la tasa de aparición de nuevos casos de una enfermedad en una población específica durante un período determinado. Para una enfermedad infecciosa, la incidencia nos informa directamente sobre la velocidad a la que se está propagando y el número de personas que están contrayendo la infección recientemente. Conocer la incidencia de una enfermedad infecciosa grave es crucial para la salud pública y la toma de decisiones clínicas. Una alta incidencia indica que la enfermedad está activamente presente en la comunidad, que la transmisión es significativa y que existe un riesgo considerable de que un mayor número de personas enfermen. Esto permite a las autoridades sanitarias y a los profesionales médicos evaluar la magnitud del problema actual, predecir futuras cargas de enfermedad, implementar medidas de control y prevención (como campañas de vacunación, aislamiento o tratamiento temprano) y asignar recursos de manera efectiva. En resumen, la incidencia capta la dinámica de la enfermedad en tiempo real, reflejando su impacto y la urgencia de su abordaje en términos de nuevos contagios. Para una enfermedad infecciosa, especialmente una grave, su "relevancia" se asocia primariamente con su capacidad de infectar a nuevas personas y expandirse en la población, siendo la incidencia la métrica que mejor describe este fenómeno.

PREGUNTA 48 **Respuesta: C**

1.10.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

Temblor Esencial: El cuadro clínico describe un temblor esencial, caracterizado por una exploración neurológica normal, salvo por temblor que aumenta con la postura o actividad. El tratamiento de elección es propranolol oral.

PREGUNTA 49 **Respuesta: C**

1.10.1.026 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Control GES

Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

El cuadro clínico presentado por el paciente de 72 años es altamente sugestivo de un **Temblor Esencial (TE)**. Las características clave son: la edad del paciente (generalmente inicia en la adultez, pero es más notorio en personas mayores), el temblor que aumenta "al adoptar una postura" (lo que define un temblor postural, principal característica del TE), la afectación de las extremidades superiores (con predominio izquierdo, lo cual puede ocurrir en el TE, aunque a menudo es bilateral), y la presencia de temblor en el mentón y la cabeza (manifestaciones clásicas del TE). La ausencia de otros hallazgos neurológicos anormales descarta otras causas de temblor, como la enfermedad de Parkinson (que presentaría bradicinesia, rigidez y temblor de reposo) o temblor cerebeloso (que se asociaría a ataxia y temblor de intención). El tratamiento de primera línea para el Temblor Esencial son los **betabloqueantes**, siendo el Propranolol el fármaco más utilizado y estudiado. Actúa reduciendo la amplitud del temblor en aproximadamente el 50-70% de los pacientes, aunque el mecanismo exacto no se comprende completamente. Se cree que su efecto está relacionado con el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos periféricos, aunque también puede tener un efecto central. La opción "Betabloqueo" se refiere directamente a esta clase de fármacos. Por lo tanto, ante un diagnóstico claro de Temblor Esencial basado en las características del temblor y la normalidad del resto del examen neurológico, el tratamiento más apropiado y de primera elección es el betabloqueo.

PREGUNTA 50 **Respuesta: C**

1.10.1.026 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Control GES

Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

El cuadro clínico presentado por el paciente de 67 años es altamente sugestivo de **Temblor Esencial (TE)**. Las características clave que apoyan este diagnóstico son: el **temblor de las extremidades superiores que aumenta al adoptar alguna postura** (lo que describe un temblor postural, principal manifestación del TE), el antecedente de que **su madre presentó un cuadro similar** (destacando el fuerte componente genético y herencia autosómica dominante en muchos casos de TE), y la **normalidad de la marcha, coordinación motora y ausencia de focalidad en el examen neurológico**. Esta ausencia de otros signos neurológicos es crucial para diferenciarlo de otras patologías como la enfermedad de Parkinson (donde se esperaría temblor de reposo, bradicinesia y rigidez) o patologías cerebelosas (con ataxia y dismetría). El **betabloqueo**, específicamente con fármacos como el propranolol (un betabloqueante no selectivo), es el tratamiento farmacológico de primera línea más ampliamente recomendado y eficaz para el Temblor Esencial sintomático. El propranolol actúa reduciendo la amplitud del temblor, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Su mecanismo exacto no está completamente dilucidado, pero se cree que ejerce sus efectos tanto a nivel periférico (bloqueo de receptores beta-2) como a nivel central. La dosis se ajusta de forma individualizada para lograr el máximo beneficio con mínimos efectos adversos.

PREGUNTA 51 **Respuesta: A**

Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

1.10.2.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paraplejia aguda" como urgencia clínica (1.10.2.011), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 52 **Respuesta: D**

Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

1.10.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Demencia por cuerpos de Lewy

PREGUNTA 53 **Respuesta: E**

Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

1.10.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Control GES

La alternativa correcta es la E (Inhibidores de la acetilcolinesterasa). En el manejo inicial del paciente con enfermedad de Alzheimer leve a moderada, los inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAChE) como donepezilo, rivastigmina y galantamina son los fármacos de primera línea. Estos medicamentos actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina en la sinapsis neuronal. Al aumentar la disponibilidad de acetilcolina, mejoran la neurotransmisión colinérgica, lo que puede resultar en una leve mejoría en la función cognitiva, el comportamiento y las actividades de la vida diaria en algunos pacientes. Las guías clínicas del MINSAL (Programa Nacional de Salud Mental) recomiendan el uso de IAChE en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, considerando la relación riesgo-beneficio y la respuesta individual de cada paciente. Es fundamental el monitoreo regular y la evaluación de la eficacia y los efectos secundarios del tratamiento.

PREGUNTA 54 **Respuesta: A**

Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

1.10.2.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo encéfalo craneano leve" como urgencia clínica (1.10.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

BLOQUE 4 PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A** **Herpes zoster**

1.10.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere

Neuritis posherpética: La sospecha clínica es de neuritis posherpética. El tratamiento de primera línea es la pregabalina o la gabapentina, siendo la pregabalina la más utilizada. La carbamazepina o los antidepresivos tricíclicos, que antes eran el tratamiento de primera línea, ahora se consideran de segunda línea.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A** **Lumbago mecánico**

1.10.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbago mecánico" (1.10.1.010), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A**

Lumbociáticas y cervicobraquialgias.

1.10.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbociáticas y cervicobraquialgias." (1.10.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 58 **Respuesta: D**

Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc...

1.10.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Cuadro clásico

PREGUNTA 59 **Respuesta: B**

Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es un síndrome de Guillain Barré clásico

PREGUNTA 60 **Respuesta: A**

Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía aguda, de origen autoinmune, que afecta principalmente a los nervios periféricos. Su característica patológica principal es la desmielinización de las raíces nerviosas y nervios periféricos. Clínicamente, esto se manifiesta como un síndrome de **neurona motora inferior**, cuyos hallazgos cardinales son: 1. **Debilidad muscular:** Típicamente simétrica y de progresión ascendente (comienza en las extremidades inferiores y avanza hacia el tronco, extremidades superiores y músculos bulbares/respiratorios). 2. **Arreflexia o hiporreflexia osteotendinosa:** La interrupción de la vaina de mielina en el nervio periférico bloquea la conducción del impulso nervioso a lo largo del arco reflejo. Esto causa la abolición o disminución severa de los reflejos. La arreflexia es un hallazgo casi universal y es un criterio diagnóstico fundamental (por ejemplo, en los criterios de Brighton para el diagnóstico de SGB). Es, por lo tanto, el signo clínico **más constante y fiable** en el examen físico. La debilidad progresa durante días o hasta 4 semanas. Aunque existen otros signos y síntomas, la arreflexia generalizada en el contexto de una debilidad progresiva es el pilar del diagnóstico clínico.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es la principal sospecha diagnóstica en este caso. La secuencia clásica es un evento infeccioso (en este caso, diarrea autolimitada) seguido por debilidad muscular ascendente y arreflexia. La parálisis facial refuerza aún más la sospecha, ya que es una manifestación común del SGB. La debilidad es progresiva y de tipo flácido, lo cual es consistente con el SGB. Según la Guía Clínica AUGE para el Síndrome de Guillain-Barré del MINSAL (aunque no se especifica un código en la lista proporcionada), el diagnóstico se basa en la clínica y se confirma con estudios como la electromiografía y el análisis del líquido cefalorraquídeo.

PREGUNTA 62 **Respuesta: B**

Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es el **Síndrome de Guillain-Barré (SGB)** porque el cuadro clínico del paciente, un adolescente de 16 años, se ajusta perfectamente a la presentación clásica de esta enfermedad. Los elementos clave son: * **Debilidad rápidamente progresiva:** La debilidad que asciende desde las extremidades inferiores a las superiores en cuestión de horas es muy sugerente de SGB. La rapidez de la progresión es fundamental. * **Arreflexia generalizada:** La ausencia de reflejos osteotendinosos (arreflexia) es un hallazgo cardinal en el SGB. Esto indica compromiso de las raíces nerviosas. * **Historia compatible:** Si bien la pregunta no lo explicita, es importante recordar que en muchos casos el SGB se presenta tras una infección respiratoria o gastrointestinal, lo que activaría una respuesta autoinmune. Si bien no se menciona en la pregunta, otros hallazgos que podrían apoyar el diagnóstico de SGB incluyen: * **Disociación albumino-citológica en el líquido cefalorraquídeo (LCR):** Aumento de la proteína en el LCR con recuento celular normal o ligeramente elevado. * **Estudios de conducción nerviosa:** Demuestran desmielinización y/o axonal en los nervios periféricos. **Guías MINSAL:** Aunque no existe una guía clínica específica del MINSAL para el manejo del SGB en adolescentes, el manejo se basa en guías internacionales y la experiencia clínica. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado son cruciales para minimizar la morbilidad y mortalidad. En Chile, el manejo suele realizarse en unidades de cuidados intensivos debido al riesgo de insuficiencia respiratoria.

PREGUNTA 63 **Respuesta: A**

Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la a) Polirradiculoneuritis desmielinizante, que es el término técnico para el Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Este diagnóstico encaja perfectamente con el cuadro clínico presentado. El paciente experimenta disestesias (alteraciones de la sensibilidad, como hormigueo o adormecimiento) en las piernas, asociadas a debilidad muscular progresiva que avanza rápidamente, impidiendo la marcha en tan solo 48 horas. Esta progresión aguda o subaguda de debilidad y síntomas sensitivos es una característica cardinal del SGB. El hallazgo más distintivo y confirmatorio en el examen físico es la arreflexia generalizada. La pérdida de los reflejos osteotendinosos profundos, especialmente de forma simétrica y generalizada, es un signo patognomónico del Síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda que afecta las raíces nerviosas y los nervios periféricos. La edad del paciente (36 años) es también compatible, ya que el SGB puede afectar a cualquier edad. La polirradiculoneuritis desmielinizante aguda se caracteriza por una respuesta autoinmune dirigida contra la mielina de los nervios periféricos y/o las raíces nerviosas. Esto interrumpe la conducción nerviosa, llevando a la debilidad motora progresiva y la afectación sensitiva. La progresión rápida y la arreflexia son los pilares diagnósticos, haciendo de esta opción la más probable y precisa para la presentación clínica del paciente.

PREGUNTA 64 **Respuesta: E**

Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

1.10.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Miastenia Gravis: El caso presentado corresponde a una miastenia gravis clásica. Se recomienda repasar el resumen de semiología neurológica.

PREGUNTA 65 **Respuesta: E**

Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

1.10.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La respuesta correcta es la e) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante. La miastenia gravis se caracteriza por debilidad muscular que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Esta fluctuación es un sello distintivo de la enfermedad. La astenia, o sensación de fatiga, es un síntoma común. La debilidad afecta a menudo los músculos que controlan los ojos (ptosis, diplopía), la masticación, la deglución y las extremidades, pero la presentación varía considerablemente entre los pacientes. La fluctuación en la gravedad de los síntomas es clave para el diagnóstico y el manejo. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular. Los anticuerpos atacan a los receptores de acetilcolina en la placa motora, interfiriendo con la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos. Esto causa debilidad muscular que varía a lo largo del día y con la actividad. El diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen físico, pruebas farmacológicas (como el test del edrofonio) y pruebas de laboratorio que detectan anticuerpos específicos. El tratamiento incluye medicamentos que mejoran la transmisión neuromuscular, inmunosupresores y, en algunos casos, timectomía.

PREGUNTA 66 **Respuesta: B**

Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

1.10.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La respuesta correcta es **b) Miastenia gravis**. Este diagnóstico se ajusta perfectamente a la presentación clínica de la paciente. La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por debilidad muscular fluctuante y fatigabilidad. Afecta predominantemente a mujeres jóvenes, lo que coincide con la edad de la paciente (33 años). Los síntomas clave en este caso son la astenia (debilidad generalizada o fatiga), la diplopía (visión doble) y la ptosis (caída del párpado), junto con un ligero estrabismo divergente. Todos estos son hallazgos clásicos de la MG, especialmente cuando afectan los músculos oculares (Miastenia Ocular), que es la forma de presentación inicial en aproximadamente el 50-60% de los casos. La característica más distintiva y crucial para el diagnóstico es la **fluctuación** de los síntomas: empeoran con la actividad o al final del día y mejoran con el reposo, lo que la paciente refiere como "fluctuantes". La evolución subaguda de 2 semanas es también consistente con el inicio de la enfermedad. La patogenia de la Miastenia Gravis implica la formación de autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular, lo que impide la transmisión eficaz del impulso nervioso a los músculos y provoca la debilidad observada. El compromiso de los músculos extraoculares y de los párpados es muy común, llevando a ptosis y diplopía. La ausencia de antecedentes previos y la aparición de estos síntomas de forma subaguda y fluctuante refuerzan aún más el diagnóstico de Miastenia Gravis.

PREGUNTA 67 **Respuesta: D**

Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

1.10.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune caracterizada por debilidad muscular fluctuante que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Los síntomas clásicos incluyen ptosis palpebral (caída del párpado), diplopía (visión doble), dificultad para hablar (disartria), dificultad para tragar (disfagia) y debilidad en las extremidades. El ejercicio exacerba la debilidad debido al agotamiento de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. En Chile, el manejo de la miastenia gravis está considerado en las Guías Clínicas del MINSAL, enfocándose en el diagnóstico precoz y tratamiento sintomático e inmunomodulador. La presentación fluctuante de los síntomas, su exacerbación con la actividad física y la presencia de diplopía son altamente sugestivas de miastenia gravis.

PREGUNTA 68 **Respuesta: D**

Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

1.10.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pregunta difícil, pero el cuadro solo es compatible con una esclerosis múltiple ya que ha tenido múltiples signos focales, de inicio subagudo, que pueden recuperarse (como el trastorno del equilibrio). Revisar el resumen de semiología neurológica.

PREGUNTA 69 **Respuesta: E**

Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

1.10.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Síndrome del Túnel Carpiano vs. Neuropatía Diabética: El paciente presenta un cuadro clínico compatible con síndrome del túnel carpiano. Se asocia a diabetes. El dolor nocturno y la desaparición de los síntomas con las actividades de la vida diaria son características distintivas del síndrome del túnel carpiano. En contraste, la neuropatía diabética simétrica sensitiva suele afectar primero a los pies y solo en etapas más avanzadas a las manos.

PREGUNTA 70 **Respuesta: E**

Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

1.10.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una ELA clásica. La espirometría mostraba un patrón restrictivo.

PREGUNTA 71 **Respuesta: E**

1.10.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Realizar GES

Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

La respuesta correcta es la **e) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón**. Este hallazgo es el más orientador de una parálisis facial periférica (o infranuclear) porque indica una afectación completa y homogénea de todos los músculos inervados por el nervio facial (VII par craneal) en el lado derecho. En una parálisis facial periférica, la lesión se localiza en el propio nervio facial, desde su núcleo en el tronco encefálico hasta su salida y ramificaciones, afectando por igual tanto las fibras que inervan la parte superior de la cara (músculo frontal para arrugar la frente, orbicular de los párpados para cerrar el ojo) como las que inervan la parte inferior (músculos de la boca, mejillas y mentón). El término "compromiso armónico" resalta esta afectación global: el paciente no podrá arrugar la frente del lado afectado, cerrar completamente el ojo (produciendo el signo de Bell), ni mover la boca o mejilla de manera simétrica (dificultad para sonreír, silbar, mostrar los dientes, y desviación de la comisura bucal hacia el lado sano). Esta distribución es clave para diferenciarla de una parálisis facial central. En contraste, una parálisis facial central (o supranuclear) se debe a una lesión en el cerebro (corteza o vías descendentes) y generalmente afecta solo la parte inferior contralateral de la cara, con preservación de la función de la frente y el ojo, debido a la inervación bilateral de los músculos de la parte superior de la cara. Por lo tanto, el compromiso armónico de todas las regiones faciales en un lado es el sello distintivo de una parálisis facial periférica.

PREGUNTA 72 **Respuesta: B**

1.10.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

El diagnóstico más probable es **Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB)**. El cuadro clínico descrito es la presentación clásica de esta patología. Analicemos las claves del caso: 1. **Desencadenante postural:** El vértigo "inició en el momento en que se levantó de la cama" y "se desencadena con los movimientos de la cabeza". Esta es la característica principal del VPPB, donde el vértigo es provocado por cambios específicos en la posición de la cabeza con respecto a la gravedad. 2. **Duración paroxística y breve:** Los episodios duran "algunos segundos". Esto es patognomónico del VPPB, cuyos episodios de vértigo rotatorio intenso suelen durar menos de un minuto. 3. **Ausencia de síntomas auditivos:** El paciente "no ha presentado síntomas auditivos" (como hipoacusia o tinnitus). El VPPB es una alteración puramente vestibular, causada por el desplazamiento de otoconias (cristales de carbonato de calcio) hacia los canales semicirculares, sin afectar la porción coclear (auditiva) del oído interno. 4. **Examen físico:** El "nistagmo horizontal" (que en el VPPB es más precisamente horizonto-rotatorio) es el signo objetivo que confirma la disfunción vestibular. Este nistagmo, al ser provocado por maniobras como la de Dix-Hallpike, típicamente tiene latencia, es de corta duración y se fatiga con la repetición de la maniobra, coincidiendo con el vértigo referido por el paciente. La combinación de vértigo rotatorio intenso, de corta duración, desencadenado por cambios posturales y sin síntomas auditivos asociados es el sello distintivo del Vértigo Postural Paroxístico Benigno.

BLOQUE 5 GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: A** **Compromiso de conciencia** 1.10.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Compromiso de conciencia" (1.10.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 74 **Respuesta: E**

1.10.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 99). Evalúa el manejo clínico de Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc) según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 75 **Respuesta: C**

Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción C describe de manera precisa y completa las características clínicas cardinales del síndrome confusional agudo, también conocido como delirium. Este trastorno neurocognitivo agudo se define por una alteración en la atención y la conciencia que se desarrolla en un período corto (horas a días), representa un cambio con respecto a la atención y conciencia basales del individuo, y tiende a fluctuar en severidad a lo largo del día. Los elementos clave que lo caracterizan son la desorientación (temporal, espacial, e incluso personal), la imposibilidad de mantener o dirigir la atención (siendo este el rasgo distintivo), y un compromiso de la conciencia o del nivel de alerta. Además, las alucinaciones (frecuentemente visuales), los delirios y la agitación psicomotora son manifestaciones comunes de las alteraciones perceptivas y cognitivas asociadas. El inicio agudo es fundamental para diferenciarlo de trastornos crónicos como las demencias.

PREGUNTA 76 **Respuesta: A**

Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción a) describe con precisión las características cardinales del síndrome delirium, también conocido como síndrome confusional agudo. El delirium es un trastorno neurocognitivo agudo caracterizado por una alteración de la atención y la conciencia que se desarrolla en un corto período de tiempo (horas a días), representa un cambio agudo respecto al nivel basal de atención y conciencia del paciente, y tiende a fluctuar en severidad a lo largo del día. La "inatención" es la característica más distintiva, manifestándose como una dificultad para dirigir, enfocar, mantener o desviar la atención. El "compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo" se refiere a una alteración en el nivel de alerta (desde somnolencia o estupor hasta hipervigilancia o agitación) y en la claridad del pensamiento y la percepción del entorno. El "inicio agudo" es fundamental para diferenciarlo de trastornos crónicos como las demencias. Estas características son los criterios diagnósticos centrales para el delirium según el DSM-5.

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La alternativa correcta es **B (Diazepam)**. El *delirium tremens* es una emergencia médica causada por la abstinencia alcohólica, caracterizada por hiperactividad autonómica (taquicardia, hipertensión, sudoración), temblor, alucinaciones (típicamente visuales), y riesgo de convulsiones. El tratamiento de elección se basa en **benzodiazepinas** (Diazepam, Lorazepam, Clordiazepóxido) debido a su efecto GABAérgico que contrarresta la hiperexcitabilidad neuronal resultante de la abstinencia. Diazepam es una opción comúnmente utilizada, especialmente si se busca una benzodiazepina de acción prolongada, aunque la elección específica depende de la disponibilidad y las características del paciente (función hepática, edad, etc.). El objetivo es la sedación suave y control de los síntomas de abstinencia, titular la dosis de manera cuidadosa. Si bien no existe una guía clínica del MINSAL específicamente sobre *delirium tremens*, el manejo de la abstinencia alcohólica severa se basa en las recomendaciones internacionales respaldadas por la evidencia y adaptadas a la realidad local.

PREGUNTA 78 **Respuesta: E**

Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La alternativa correcta es **E: Delirium**. El cuadro clínico describe una alteración aguda y fluctuante de la cognición, con inicio reciente (días), alteración del nivel de conciencia (apatía, agitación, insomnio) y alteraciones del pensamiento (incoherencias, desorientación). Estos son los criterios cardinales para el diagnóstico de Delirium. El antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, aunque no causan directamente el delirium, pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo, especialmente en un contexto de estrés fisiológico o metabólico. La pérdida leve de memoria previa podría ser un factor predisponente, pero la rapidez de la instalación del cuadro actual apunta fuertemente al delirium. Según la Guía Clínica del MINSAL para el manejo del Delirium, este se define como un síndrome neuropsiquiátrico agudo caracterizado por alteración de la atención, conciencia y cognición, que se desarrolla en un corto período de tiempo (horas a días) y tiende a fluctuar a lo largo del día. En este caso, la evolución en días, la fluctuación del estado mental (apatía seguida de agitación) y la alteración de la cognición (incoherencias, desorientación) son consistentes con Delirium.

PREGUNTA 79 **Respuesta: A**

Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente, la conducta médica prioritaria es: El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente, la conducta médica prioritaria es: El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La pregunta se refiere a la interpretación de los resultados de una densitometría ósea en una mujer postmenopáusica, que es una situación clínica común evaluada en endocrinología. Para clasificar la densidad mineral ósea (DMO), se utilizan principalmente el T-score y, en menor medida, el Z-score. Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el T-score es el parámetro clave para diagnosticar osteopenia u osteoporosis en mujeres postmenopáusicas (como la paciente de 55 años) y hombres mayores de 50 años. Los criterios de la OMS son los siguientes: * **DMO normal**: T-score igual o superior a -1.0 desviación estándar (DS). * **Osteopenia (baja masa ósea)**: T-score entre -1.0 y -2.5 DS. * **Osteoporosis**: T-score igual o inferior a -2.5 DS. * **Osteoporosis grave establecida**: T-score igual o inferior a -2.5 DS y la presencia de una o más fracturas por fragilidad. En el caso presentado, la paciente de 55 años tiene un T-score de -2.3 DS. Este valor se encuentra claramente entre -1.0 y -2.5 DS, lo que corresponde al diagnóstico de osteopenia. El Z-score de -1 DS compara la densidad ósea del paciente con la de personas de su misma edad y sexo. Aunque se menciona, el Z-score es más relevante para evaluar la DMO en niños, mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, donde un T-score negativo podría ser normal para la edad. Sin embargo, en una mujer postmenopáusica de 55 años, el T-score es el criterio diagnóstico definitivo.

PREGUNTA 82 **Respuesta: A**

Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La alternativa correcta es **A (Caídas a nivel)** porque la mayoría de las fracturas de cadera, especialmente en adultos mayores, se producen como resultado de caídas desde la propia altura. La fragilidad ósea asociada a la osteoporosis, común en este grupo etario, disminuye la resistencia del hueso, haciéndolo más susceptible a fracturas incluso con traumatismos de baja energía como una caída a nivel. La prevalencia de caídas a nivel es significativamente mayor que otras causas en la población de riesgo, según datos epidemiológicos y guías clínicas nacionales e internacionales. Aunque no hay una guía clínica MINSAL específica para fracturas de cadera, las guías sobre osteoporosis enfatizan la prevención de caídas como una medida clave.

PREGUNTA 83 **Respuesta: A**

Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI), la conducta médica prioritaria es: La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 84 **Respuesta: A**

Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI), la conducta médica prioritaria es: La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 85 **Respuesta: B**

Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial / Derivación · Seg: Urgencia traumatológica / Ortogeriatría GES

La alternativa correcta es la B porque la presentación clínica clásica de una fractura de cadera en el adulto mayor (grupo etario donde son más frecuentes) se caracteriza por: * **Acortamiento del miembro afectado:** Esto se debe a la tracción de los músculos de la cadera y el muslo sobre el fragmento distal de la fractura. * **Rotación externa del muslo:** La rotación externa es causada por la pérdida de la integridad ósea y la influencia de la gravedad y la tensión muscular, especialmente los rotadores externos de la cadera. * **Abducción del muslo:** Puede presentarse levemente debido a la posición antiálgica que adopta el paciente. * **Imposibilidad de caminar:** La fractura impide la carga de peso y el movimiento normal de la articulación de la cadera, generando dolor intenso e incapacidad funcional. En las guías clínicas chilenas del MINSAL no hay una específica sobre fractura de cadera, pero sí se enfatiza la importancia de la evaluación geriátrica integral en pacientes adultos mayores, donde la detección y manejo de fracturas de cadera es fundamental para disminuir la morbimortalidad.

PREGUNTA 86 **Respuesta: A**

Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial / Derivación · Seg: Urgencia traumatológica / Ortogeriatría GES

El Atenolol, al ser un betabloqueante selectivo beta-1, es un fármaco que se asocia con un mayor riesgo de caídas en el paciente anciano debido a sus efectos cardiovasculares y, en menor medida, potenciales efectos en el sistema nervioso central. En la población geriátrica, la fisiología cardiovascular está alterada, con una respuesta barorrefleja más lenta y una menor reserva funcional. Los betabloqueantes reducen la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, lo que puede precipitar o exacerbar la hipotensión ortostática (una caída significativa de la presión arterial al ponerse de pie), causando mareos, aturdimiento y síncope. Estos síntomas de hipotensión ortostática o bradicardia son directamente predisponentes a la pérdida de equilibrio y, consecuentemente, a las caídas. Además, aunque el Atenolol es hidrofílico y tiene una menor penetración en el sistema nervioso central en comparación con otros betabloqueantes más lipofílicos, aún puede causar efectos como fatiga, debilidad o ligera sedación en algunos individuos, lo que también contribuye a una marcha inestable y un mayor riesgo de caídas. La polifarmacia, común en el adulto mayor, incrementa este riesgo al interactuar con otros fármacos que también pueden afectar el equilibrio o la presión arterial.

PREGUNTA 87 **Respuesta: A**

Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial / Derivación · Seg: Urgencia traumatológica / Ortogeriatría GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES, la conducta médica prioritaria es: Más del 90% de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a nivel desde su propia altura sobre hueso osteoporótico.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 88 **Respuesta: B**

Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

1.07.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La hemorragia subconjuntival post-traumática, en ausencia de otros signos de alarma, generalmente es autolimitada y no requiere intervención urgente por un especialista. Se produce por la rotura de pequeños vasos sanguíneos bajo la conjuntiva, generalmente por un traumatismo leve, un esfuerzo (tos, vómito) o, a veces, sin causa aparente. El manejo suele ser expectante, con lubricación ocular si hay molestias. Si es recurrente o asociada a alteraciones de la coagulación o uso de anticoagulantes, se debe investigar la causa.

PREGUNTA 89 **Respuesta: C**

Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

1.07.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

El caso clínico describe a una paciente con **Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU)**, también conocida como síndrome de vejiga hiperactiva "húmeda". El diagnóstico se basa en la sintomatología clave: "deseos incontrolables de orinar" (urgencia miccional) que provocan una pérdida involuntaria de orina antes de llegar al baño. El manejo de la IUU sigue un enfoque escalonado: 1. **Descartar causas reversibles:** Se realizó un urocultivo y sedimento de orina para descartar una infección del tracto urinario (ITU), que puede causar síntomas similares. Los resultados normales confirman que no hay una ITU. 2. **Tratamiento de primera línea:** Consiste en terapia conductual (ajuste de ingesta de líquidos, micciones programadas) y entrenamiento de los músculos del piso pélvico (ejercicios de Kegel). En el caso, estas medidas ya se indicaron y resultaron ineficaces. 3. **Tratamiento de segunda línea:** Cuando la primera línea falla, se inicia el tratamiento farmacológico. La fisiopatología de la IUU implica contracciones involuntarias del músculo detrusor de la vejiga, que está mediado principalmente por la estimulación colinérgica a través de receptores muscarínicos. Por lo tanto, los fármacos **anticolinérgicos (o antimuscarínicos)** son el tratamiento de elección. Estos medicamentos (como la oxibutinina, tolterodina o solifenacina) bloquean dichos receptores, relajando el músculo detrusor, aumentando la capacidad de la vejiga y disminuyendo la sensación de urgencia. Dado que la paciente ya falló al tratamiento de primera línea, el siguiente paso correcto y más adecuado es iniciar la farmacoterapia con anticolinérgicos.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

1.07.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor, la conducta médica prioritaria es: La polifarmacia (≥ 5 fármacos) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa corporal, declive renal) multiplican el riesgo de RAM y caídas.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.
